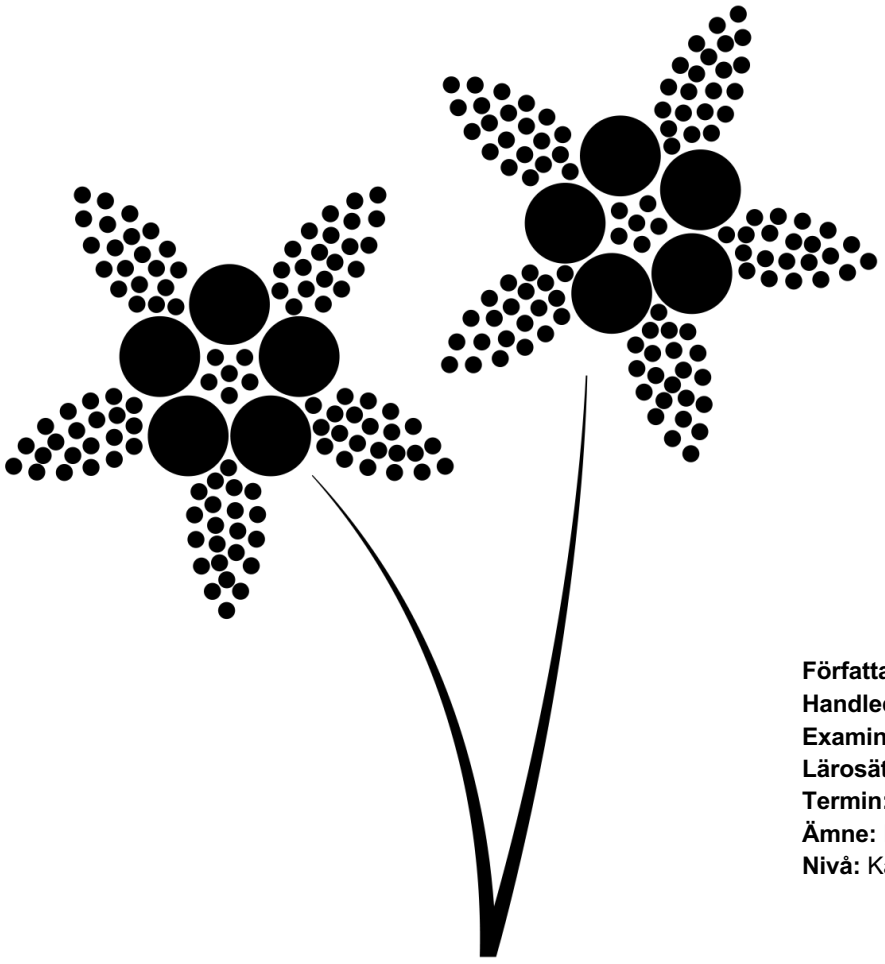
Linnéuniversitetet

# Att navigera organisatoriska och professionella barriärer

## En jämförande fallstudie om implementering av strategisk HRM i svensk hälso- och sjukvård



**Författare:** Robin Weine
**Handledare:** Fredrik Karlsson
**Examinator:** Frederic Bill
**Lärosäte:** Linnéuniversitetet
**Termin:** HT2025
**Ämne:** Företagsekonomi
**Nivå:** Kandidatexamen

Linnéuniversitetet

## *Förord*

Detta examensarbete inom företagsekonomi har till stor del fått sin inspiration från en akademisk och professionell bakgrund inom svensk sjukvård som legitimerad fysioterapeut. Med denna förförståelse har en forskningsfråga utifrån ett organisatoriskt perspektiv uppkommit, varifrån denna studie har utvecklats.

Med detta vill jag tacka respondenter som bidragit med värdefull insyn i sina respektive organisationer och deras processer vilket har möjliggjort denna studie. Jag vill även passa på att tacka handledare och kurskamrater för vägledning och konstruktiva synpunkter under arbetets gång.

Stockholm / 11 januari 2026

*Robin Weine*

# Sammanfattning

Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE95E, ht25

**Författare:** Robin Weine

**Handledare:** Fredrik Karlsson

**Examinator:** Frederic Bill

**Titel:** *Att navigera organisatoriska och professionella barriärer: En jämförande fallstudie om implementering av strategisk HRM i svensk hälso- och sjukvård*

Hälso- och sjukvården präglas av komplexa strukturer, starka professionskulturer och begränsade resurser, vilket skapar utmaningar för implementering av strategisk personalstyrning (SHRM). Skillnader mellan offentliga och privata vårdgivare påverkar möjligheten att koppla personalstrategier till organisatoriska mål, samtidigt som värdebaserad vård betonar HRM:s roll för effektivitet och patientvärde. Syftet med studien är att undersöka hur HR-aktörer inom svensk hälso- och sjukvård uppfattar och tolkar barriärer vid implementering av SHRM, samt hur dessa upplevelser skiljer sig mellan offentliga och privata vårdgivare.

Studiens metod är av kvalitativ komparativ fallstudiedesign med åtta semistrukturerade intervjuer av nyckelaktörer med strategisk insyn i HR-frågor och dess tillämpning. Urvalet kommer från vårdinrättningar med olika former av huvudmannaskap, varvid offentlig och privat sektor representeras via respondenterna. Datan analyserades med tematisk analys utifrån ett kritiskt realistiskt perspektiv. Analysen syftade till att identifiera teman som belyser både gemensamma och kontextspecifika barriärer, samt att förstå mekanismer som påverkar HR-strategiernas genomslag i olika organisatoriska miljöer.

Resultaten indikerar att SHRM i praktiken påverkas av både organisatoriska och professionella barriärer, såväl som viss mån av kontextuella skillnader. Upplevelser av tveksamhet, syn som administrativ börda samt organisatoriska hinder framställer HR-initiativ som ifrågasatta. Trots en upplevelse av privata inrättningar som flexiblare och mer anpassningsbara till strategiska initiativ så kvarstår en grad av autonomi från vårdens professioner. Sammantaget indikerar resultaten att framgångsrik implementering kräver att HR-strategier är anpassade till både kontext så väl som professionerna den ämnar nå ut till.

**Nyckelord:** strategiskt handlingsutrymme, organisatoriska faktorer, offentlig och privat sektor, implementeringsutmaningar

# Abstract

Bachelor Thesis, Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE95E, Autumn 2025

**Author:** Robin Weine

**Advisor:** Fredrik Karlsson

**Examinator:** Frederic Bill

**Title:** *Navigating Organizational and Professional Barriers: A Comparative Case Study on the Implementation of Strategic HRM in Swedish Health Care*

Healthcare is characterised by complex structures, strong professional cultures and limited resources, which create challenges for the implementation of Strategic Human Resource Management (SHRM). Differences between public and private healthcare providers affect the ability to align HR strategies with organisational objectives, while value creating healthcare emphasises the role of HRM in enhancing efficiency and patient value. Purpose of the study is to examine how HR actors within Swedish healthcare perceive and interpret barriers to implementation of SHRM and how these perceptions differ between public and private healthcare.

The study employs a qualitative comparative case study design based on eight semi-structured interviews with key actors possessing strategic insight into HR issues and their application. Sample is drawn from healthcare organisations with different forms of ownership, with both public and private sectors represented. Data was analysed using thematic analysis from a critical realistic perspective, seeking to identify themes highlighting both shared and context-specific barriers, as well as to understand the mechanisms influencing the impact of HR strategies across different organisational environments.

Findings indicate that SHRM in practice is influenced by both organisational and professional barriers and to some extent contextual differences. Experiences of scepticism, HR as an administrative burden and organisational constraints contribute to HR initiatives being questioned. Despite private organisations being perceived as more flexible and adaptable to strategic initiatives, a degree of autonomy among healthcare professionals remains. Overall, the results suggest successful implementation requires HR strategies to be adapted to both organisational context and professional groups they seek to engage.

**Keywords:** strategic room for manoeuvre, organizational factors, public and private sector, implementation challenges

Linnéuniversitetet

# Innehållsförteckning


**1 Introduktion ..... 1**
1.1 Bakgrund ..... 1
1.1.1 Strukturella utmaningar ..... 1
1.1.2 Personalstrategi ..... 1
1.1.3 Organisatoriska utmaningar vid implementering ..... 2
1.1.4 Professionella utmaningar vid implementering ..... 3
1.2 Problemdiskussion ..... 3
1.2.1 Betydelsen av strategi och implementering i organisationer ..... 3
1.2.2 Förändringsagenter och överbryggning av barriärer ..... 4
1.2.3 Kunskapsluckor och organisatoriska skillnader ..... 4
1.3 Syfte ..... 5
1.4 Frågeställning ..... 5
1.5 Avgränsning ..... 5

**2 Metod ..... 6**
2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt ..... 6
2.2 Kvalitativ fallstudie med komparativ design ..... 6
2.3 Urval av fall och respondenter ..... 7
2.4 Datainsamling ..... 7
2.5 Dataanalys ..... 7
2.6 Forskningsetiska överväganden ..... 8
2.7 Metodkritik och begränsningar ..... 8

**3 Teoretisk referensram ..... 9**
3.1 Professionell autonomi och kulturella barriärer ..... 9
3.2 Organisatoriska barriärer för implementering ..... 9
3.3 Legitimitet, samverkan och strategiskt ledarskap ..... 10
3.4 Kontextuella skillnader mellan privat och offentlig vård ..... 10
3.5 Teoretisk förankring av intervjuteman ..... 11

**4 Empiri ..... 12**
4.1 Respondenter och datamaterial ..... 12
4.2 Kontextuella skillnader ..... 13
4.2.1 Styrningslogik och beslutsprocesser ..... 13
4.2.2 Position och grundläggande uppdrag ..... 13
4.2.3 Organisatoriska strukturer och hinder ..... 14
4.2.4 Profesionell logik och kliniska normer ..... 14
4.3 Organisatoriska hinder för strategiskt arbete ..... 15
4.3.1 Struktur och ansvarsfördelning ..... 15
4.3.2 Resurser och administrativa krav ..... 16
4.4 Professionella hinder för strategiskt arbete ..... 16
4.4.1 Klinisk logik och dess inverkan ..... 16
4.4.2 Professionsnormer och yrkesidentitet ..... 17
4.4.3 Uppfattning som administrativ funktion ..... 17
4.5 Strategiska mekanismer ..... 17
4.5.1 Delaktighet och förankring ..... 17
4.5.2 HR som strategisk partner ..... 18
4.5.3 Ledarskap och ambassadörer som drivkraft ..... 19
4.5.4 Lokala anpassningar och balansering av strategi ..... 19

**5 Analys ..... 20**
5.1 Övergripande skillnader ..... 20
5.2 Kontextuella skillnader i implementering ..... 21

5.2.1 Styrningslogik, beslutsprocesser och organisatorisk tröghet ..... 21
5.2.2 Organisatorisk position och handlingsutrymme ..... 21
5.2.3 Lokala anpassningar och flexibilitet ..... 22
5.3 Organisatoriska faktorers inverkan ..... 22
5.3.1 Proffesioner som hinder ..... 22
5.3.2 Organisatorisk flexibilitet ..... 22
5.4 Profesionella faktorers inverkan på implementering ..... 23
5.4.1 Klinikers logik och arbetsfokus ..... 23
5.4.2 Professionsnormer och yrkesidentitet ..... 24
5.5 Strategiska möjliggörare ..... 24
5.5.1 Legitimitet och implementering i professionella organisationer ..... 24
5.5.2 Strategisk översättare mellan mål och praktik ..... 25
**6 Diskussion ..... 27**
6.1 Reflektion kring metod ..... 27
6.2 Reflektion kring empiri ..... 27
6.3 Diskussion kring resultat ..... 28
6.4 Relation till tidigare forskning ..... 28
6.5 Förslag på vidare forskning ..... 29
**7 Slutsats ..... 30**
**8 Referenser ..... 31**

# Bilagor

Bilaga 1: Mejl till respondenter

Bilaga 2: Intervjuguide

Bilaga 3: Översikt över respondenter

Bilaga 4: Kodningsschema

# 1 Introduktion

*Inledande kapitlet presenterar en bakgrund till de utmaningar som präglar implementeringen av strategisk personalstyrning inom hälso- och sjukvård. Kapitlet belyser organisatoriska, professionella och resursmässiga barriärer samt dess inverkan på HR-aktörers förutsättningar att arbeta strategiskt.*

## 1.1 Bakgrund

### 1.1.1 Strukturella utmaningar

Denna studie behandlar implementeringen av strategisk human resource management (SHRM) inom svensk sjukvård, en kontext där organisatoriska strukturer och professionskulturer skapar utmaningar för personalstyrning. Hälso- och sjukvården präglas av komplexa strukturella faktorer såsom demografiska förändringar, en åldrande befolkning, ökade krav på effektivitet och snabb teknologisk utveckling, vilka sammantaget gör vårdsystemen svårstyrda och resurskrävande (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013; Meskó et al., 2017). Samtidigt råder generellt en brist på kvalificerad personal, framför allt för sjuksköterskor och läkare, vilket ökar belastningen på organisationer och försvårar långsiktig kompetensförsörjning (Buchan & Aiken, 2008; McHugh et al., 2011).

Sjukvårdens utmaningar får särskild betydelse i en kontext där huvudmän och styrningslogiker skiljer sig åt, såsom mellan offentliga och privata vårdgivare. Offentliga aktörer verkar ofta inom snävare ramar av budget, regelverk och politisk styrning, medan privata aktörer kan ha större autonomi i HR-frågor och organisatoriska beslut (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013; Socialstyrelsen, 2024). Skillnader i styrning och organisatoriska förutsättningar påverkar således möjligheterna att implementera SHRM och värdebaserade personalstrategier. Strategisk personalstyrning (SHRM) syftar till att integrera HR-praktiker med organisatoriska mål för att optimera resursanvändning, stärka kompetensförsörjning och förbättra prestationsnivåer (Wright, Dunford & Snell, 2001; Becker & Huselid, 2006; Paauwe, 2009). Inom vården försvåras detta arbete av starka professionsidentiteter och komplexa organisatoriska strukturer, vilket ofta leder till ett glapp mellan strategiska intentioner och operativ implementering (Freidson, 2001; Boxall & Purcell, 2016).

Parallellt har ett ökat fokus riktats mot skapande av värde för patienter, framför allt den hälsa som uppnås i relation till använda resurser (Porter, 2010). För att uppnå högre värde krävs inte enbart kliniska förbättringar, utan även strategisk integrering av HR-arbete, ledarskap och organisatoriskt lärande. Detta understryker att personalstrategier inte kan betraktas som isolerade funktioner, utan som en del av ett bredare reformarbete som syftar till att öka kvalitet, effektivitet och hållbarhet inom vården (Porter & Teisberg, 2006; Swanwick & McKimm, 2017).

### 1.1.2 Personalstrategi

Strategisk personalstyrning (SHRM) har blivit en central komponent inom hälso- och sjukvården, där ökade krav på effektivitet, kvalitet och långsiktig hållbarhet enligt Wright och McMahan (2011) samt Paauwe (2009) gör det nödvändigt att personalfrågor integreras med organisationens övergripande mål. SHRM kan definieras som ett systematiskt och sammanhållet sätt att hantera personal, inklusive rekrytering,

kompetensutveckling, ledarskap och belöningssystem med syfte att stärka både individuella och organisatoriska prestationer (Lepak & Snell, 1999; Guest, 2011).

Forskning indikerar att välutformade HR-strategier kan bidra till förbättrade patientutfall, högre arbetsnöjdhet och minskad personalomsättning (McHugh et al., 2011; Martineau et al., 2023). Implementeringen av SHRM inom vårdsektorn sker dock i ett komplext organisatoriskt kontext. Organisationer präglas av stark professionskultur, hierarkiska strukturer och politisk styrning, vilket ofta skapar både barriärer och hinder för strategiska HR-praktiker (Noordegraaf, 2015; Boxall & Purcell, 2016).

Med *barriärer* avses strukturella eller institutionella faktorer som begränsar möjligheten att införa förändringar, exempelvis resursbegränsningar, vertikala beslutsstrukturer eller politiska regelverk. *Hinder* syftar i stället på aktörsbaserade eller kulturella faktorer, såsom yrkesgruppers normer, värderingar och prioriteringar, som påverkar mottagandet av nya strategier (Polder & Jochemsen, 2000; Freidson, 2001). Professionell autonomi är särskilt framträdande inom vården, där kliniska yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor utgör starka intressenter som kan både möjliggöra och begränsa förändringsinitiativ (Kitchener, 2002; Spehar, Frich & Kjekshus, 2012).

Organisatoriska faktorer bidrar samtidigt till ytterligare komplexiteten där resursbegränsningar, administrativa processer och fragmenterade beslutsstrukturer gör att förändringsarbete ofta går långsamt eller delas upp i separata initiativ (Christensen & Lægreid, 2007; Salge & Vera, 2012). HR-frågor tenderar att hanteras operativt snarare än strategiskt, vilket kan minska deras genomslag i den dagliga verksamheten (Ulrich & Dulebohn, 2015).

Forskning understryker därför vikten av att utforma HRM-system som är både tekniskt välutvecklade och kontextuellt anpassade till vårdens organisatoriska och professionella realiteter (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013; Kaufman, 2015). För att implementeringen ska bli hållbar krävs enligt Townsend, Wilkingson och Allan (2013) samt Tourangeau et al (2010) behövs legitimitet inom yrkesgrupper, stöd från ledning och förmåga att anpassa strategier till både offentlig och privat styrning, där organisatoriska villkor och autonomi varierar mellan huvudmän.

### 1.1.3 Organisatoriska utmaningar vid implementering

Implementeringen av personalstrategier inom hälso- och sjukvården påverkas starkt av organisatoriska faktorer som kan fungera som barriärer eller hinder enligt bland andra Kristensen et al (2019). I denna studie definieras barriärer som djupare, ofta strukturella eller kulturella faktorer som begränsar implementeringen av strategiska HR-praktiker, medan hinder avser mer konkreta, situationsspecifika problem som exempelvis bristande kommunikation eller otydligt ledarskap som lyfts av Bowles, McEwen och Boutin-Foster (2017) samt Kristensen et al (2019).

Hierarkiska strukturer, byråkratiska processer och långsamma beslutsvägar är exempel på organisatoriska barriärer som kan fördröja förändringsarbete och begränsa flexibiliteten i personalhantering (Christensen & Lægreid, 2007; Salge & Vera, 2012). Resursbrist, både avseende personal och ekonomiska medel, utgör ytterligare hinder för implementering av långsiktigt hållbara HR-strategier (Buchan & Aiken, 2008; Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013).

En aspekt som potentiellt kan påverka sjukvårdens organisationer är form av styrning och förutsättningar för implementering av personalstrategier. Offentligt finansierade organisationer i den mån att organisationen i sin helhet är styrd av det offentliga har

rapporterats som präglat av reglerings- och rapporteringskrav, något som kan inverka på HR:s möjligheter till implementeringar (Anell, Glenngård & Merkur, 2012). Parallellt har privata vårdgivare i form av företag som är skattefinansierade men verkar inom vårdsektorn potential att verka med större autonomi och flexibilitet i beslutsfattande och personalstrategi, vilket kan potentiellt resultera i snabbare förändringsarbete (Ludvigsson et al., 2025).

Samtidigt får ledarskapets betydelse inte underskattas då chefer måste både förstå och respektera professionella normer samtidigt som de aktivt driver organisatorisk förändring. Brist på HR-kompetens hos chefer och otydlig ansvarsfördelning mellan kliniska och administrativa roller kan skapa hinder för genomförande (Tourangeau et al., 2010; Townsend, Wilkinson & Allan, 2013). Framgångsrik implementering kräver således att HR integreras i organisationens kärnstrategi snarare än att fungera som en isolerad funktion (Paauwe, 2009; Boxall & Purcell, 2016).

### 1.1.4 Professionella utmaningar vid implementering

Utöver organisatoriska faktorer påverkas potentiellt implementeringen av strategiska personalstrategier av professionella barriärer. Hälso- och sjukvården domineras av starka professionella grupper som har hög autonomi och definierar sin yrkesidentitet utifrån klinisk expertis snarare än organisatoriska mål (Freidson, 2001; Noordegraaf, 2015). Denna autonomi kan både möjliggöra och begränsa förändringsinitiativ, särskilt när HR-strategier upplevs som top-down-styrda eller saknar tydlig klinisk relevans (Kitchener, 2002; Spehar, Frich & Kjekshus, 2012).

Tidigare forskning tyder på att legitimitet inom yrkesgrupper och stöd från ledning är avgörande för framgångsrik implementering (Tourangeau et al., 2010; Townsend, Wilkinson & Allan, 2013). Professionella barriärer kan övervinnas genom delaktighet, kommunikation och engagemang i förändringsprocessen. Detta kräver att HR-strategier inte endast är tekniskt välutformade utan också kontextuellt anpassade till vårdens professionella logik (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013; Kaufman, 2015). Skillnader mellan huvudmän påverkar även professionella utmaningar. I offentliga organisationer kan starka regleringskrav och politiska styrningsprinciper förstärka motstånd mot förändring, medan privata aktörer ofta har möjlighet att involvera personal mer direkt i strategiska beslut, vilket kan minska professionellt motstånd (Anell, Glenngård & Merkur, 2012; Ludvigsson et al., 2025).

## 1.2 Problemdiskussion

### 1.2.1 Betydelsen av strategi och implementering i organisationer

Strategisk styrning och dess implementering är centrala för att organisationer ska uppnå sina mål och skapa långsiktigt värde, särskilt i komplexa och resurskrävande sektorer som hälso- och sjukvården (Pettigrew, 1997; Mintzberg, 2017). Strategisk personalstyrning (SHRM) fungerar som en bro mellan organisatoriska mål och personalpolitik, med syfte att optimera både effektivitet och kvalitet i vårdkedjan (Wright & McMahan, 2011). I praktiken uppstår ofta ett glapp mellan strategi och implementering, där formulerade policyer inte nödvändigtvis leder till förändring på operativ nivå (Fitzgerald et al., 2002; Andrieiev et al., 2024).

En central aspekt är att sjukvården baseras på värde där vårdens struktur och processer organiseras för att maximera patientvärde och hälsa i relation till kostnad (Porter & Teisberg, 2006; Porter, 2008). Detta kräver att både organisatoriska strukturer, personalstyrning och styrlogiker justeras för att möjliggöra en värdeorienterad vård. I

praktiken innebär detta att vårdteam organiseras runt antalet patienter som organisationen behandlar och att resultat mäts både i värden viktiga för patientens hälsa, samt att allmänhetens resurser används för maximal nytta.

Implementering påverkas dock av professionell autonomi och organisatoriska kontexter där professionella grupper, såsom läkare och sjuksköterskor, tolkar och omsätter strategier utifrån klinisk expertis och yrkesidentitet snarare än organisatoriska mål (Freidson, 2001; Noordegraaf, 2015). I Sverige, där sjukvården utförs av både offentliga och privata aktörer under gemensam finansiering, skiljer sig potentiellt möjligheterna att implementera personalstrategier mellan huvudmän. Privata aktörer kan potentiellt agera mer flexibelt i HR-frågor, medan offentliga organisationer verkar inom snävare politiska och ekonomiska ramar, vilket kan påverka legitimitet och genomförbarhet (Socialstyrelsen, 2024; Glenngård & Malmi, 2025).

### 1.2.2 Förändringsagenter och överbryggning av barriärer

Tidigare forskning visar att formella och informella förändringsagenter är avgörande för att överbrygga glappet mellan strategiska ambitioner och operativ verklighet (Ferlie et al., 2013). I vårdsektorn är motstånd mot förändring ofta förankrat i legitima professionella normer och organisatorisk tröghet snarare än ovilja. Därför behöver förändringsagenter förstå både den strategiska logiken bakom reformer och de operativa konsekvenserna för personal och arbetsprocesser (Martin, Currie & Finn, 2009).

Implementering handlar således inte enbart om tekniska system eller ekonomiska incitament, utan också om kulturella och institutionella villkor. Dialog, delaktighet och tillit har lyfts som centrala mekanismer för att skapa acceptans och legitimitet, särskilt när nya personalstrategier påverkar yrkesroller och ansvar (Fitzgerald et al., 2002; Greenhalgh et al., 2004). Framgångsrika förändringsagenter fungerar därmed som brobyggare mellan organisationens mål och professionella logiker och anpassar HR-initiativ till den organisatoriska kontexten.

### 1.2.3 Kunskapsluckor och organisatoriska skillnader

Det svenska sjukvårdssystemet präglas av decentraliserad styrning och ett starkt regionalt ansvar, vilket skapar unika organisatoriska utmaningar för implementering av strategiska personalstrategier (Ludvigsson et al., 2025). Kombinationen av politiska styrmekanismer, decentraliserat beslutsfattande och professionell autonomi förstärker potentiellt barriärerna för effektiv implementering (Glenngård & Malmi, 2025). Trots omfattande teoribildning kring SHRM, nyttomaximering och vård baserad på värdeoptimering kvarstår flera kunskapsluckor. Särskilt saknas förståelse för hur organisatoriska och professionella barriärer interagerar inom olika typer av vårdgivare, inklusive jämförelser mellan offentliga och privata huvudmän (Spehar, Frich & Kjekshus, 2012; Glenngård & Malmi, 2025).

Få studier undersöker hur liknande typer av strategi, exempelvis implementering av värdebaserade HR-praktiker, realiseras i olika organisationsformer, trots att skillnader i styrning, kultur och ansvarsfördelning sannolikt påverkar resultatet (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013). Samtidigt som resultat från andra studier om organisationsteorier kan appliceras genom generalisering så lyfter Lega, Prenestini och Spurgeon (2013) att sjukvårdens nationella säregenheter gör det svårt att dra en konkret slutsats om idealisk tillämpning. Således kan resultaten från bland annat Welker et al (2014) rörande förändringsagenters roll i kvalitetsförbättring variera mellan sjukvårdssytem.

Följden blir att studier om strategiska beslut (Andrieiev et al., 2024), hur man löser bemanning genom hållbara personalstrategier (Buchan and Aiken, 2008), optimering av

effektivitet genom att inte förbise HR samt inverkan av offentlig sektor (Christensen & Lægreid, 2007; Gile, van de Klundert & Buljac-Samardzic, 2022) I hög grad blir kontextbundna. Denna kunskap är avgörande för att utforma HR-strategier som både är tekniskt hållbara och organisatoriskt anpassade till den svenska kontexten med olika former av huvudmän inom hälso- och sjukvård. Denna studie syftar till att bidra med empiriskt grundade insikter om de specifika utmaningar som nyckelaktörer upplever vid implementering av SHRM i olika vårdmiljöer inom det svenska kontextet, snarare än att generalisera resultaten till hela vårdsektorn.

## 1.3 Syfte

Syftet med studien är att kartlägga hur HR-aktörer inom svensk hälso- och sjukvård uppfattar och tolkar organisatoriska, professionella och resursmässiga barriärer som påverkar implementeringen av strategisk personalstyrning, samt att analysera hur och varför dessa uppfattningar skiljer sig mellan offentliga och privata vårdgivare.

## 1.4 Frågeställning

Hur uppfattar och tolkar HR-aktörer inom svensk hälso- och sjukvård de organisatoriska, professionella och resursmässiga barriärer som påverkar implementeringen av strategisk personalstyrning, och på vilka sätt samt av vilka skäl skiljer sig dessa uppfattningar mellan offentliga och privata vårdorganisationer?

## 1.5 Avgränsning

Studien begränsar sig till faktorer på organisatorisk och professionell nivå och inkluderar därför inte bredare policyfrågor, finansiella strukturer eller teknologiska aspekter.

# 2 Metod

*Kapitlet redogör för studiens metodologiska ansats och tillvägagångssätt. En kvalitativ komparativ fallstudiedesign används för att undersöka barriärer i implementeringen av strategisk personalstyrning inom hälso- och sjukvården. Kapitlet behandlar vetenskapsteoretisk utgångspunkt, urval, datainsamling, analys samt etiska och metodologiska överväganden.*

## 2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Denna studie utgår från ett kritiskt realistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att verkligheten består av både observerbara och icke-observerbara strukturer som påverkar sociala och organisatoriska processer (Bhaskar, 1978; Danermark et al., 2002). Kritisk realism förenar ontologisk realism, tron på en oberoende verklighet med epistemologisk relativism där all kunskap om verkligheten förstås som teoretiskt tolkad och socialt medierad (Sayer, 2000). Forskningens uppgift är därmed inte att fastställa absoluta sanningar, utan att identifiera och förklara de underliggande mekanismer som genererar observerbara fenomen.

Tillämpat på denna studie innebär det att organisatoriska hinder, professionell autonomi och HR-strategiers genomslag förstås som uttryck för djupare liggande strukturer som exempelvis styrlogiker, professionsnormer och institutionella ramar vilka påverkar aktörers tolkningar, handlingsutrymme och organisatoriskt agerande även om de inte alltid är direkt synliga i empiriska utsagor. Kritisk realism är särskilt relevant vid studier av komplexa organisationer som hälso- och sjukvården, där flera olika logiker, aktörer och strukturer samverkar (Fletcher, 2016).

Genom att kombinera kvalitativ empiri i form av semistrukturerade intervjuer med teoretiskt informerad analys syftar studien till att generera både beskrivande och förklarande insikter om hinder som påverkar implementeringen av strategisk personalstyrning i olika organisatoriska kontexter. Den kritiskt realistiska ansatsen hänger nära samman med ett abduktivt förhållningssätt (Dubois & Gadde, 2002), där tolkningar utvecklas iterativt i växelverkan mellan teori och empiri där initiala teoretiska antaganden kan omprövas i ljuset av empiriska fynd, samtidigt som empiriska observationer fördjupas genom teoretisk begreppsbildning.

## 2.2 Kvalitativ fallstudie med komparativ design

Studien bygger på en kvalitativ fallstudieansats med komparativ design, där två former av huvudmannaskap för sjukhus i Sverige, offentligt och privat, studeras för att fördjupa förståelsen av hur organisatoriska och professionella hinder påverkar implementeringen av strategisk personalstyrning. Genom att undersöka två fall med olika institutionella villkor skapas möjligheter att identifiera både gemensamma mönster och kontextspecifika skillnader.

Valet av två organisationer grundas i analytiskt syfte snarare än generalisering. Den komparativa ansatsen stärker studiens potential att synliggöra hur olika styrformer, professionella logiker och organisatoriska strukturer formar aktörers uppfattningar om hinder och möjligheter i implementeringsprocessen (Yin, 2018). Detta är särskilt relevant i en svensk kontext där vården bedrivs under olika huvudmannaskap, vilket kan påverka HR-funktionens handlingsutrymme och legitimitet.

Andra designalternativ såsom att studera enbart offentlig vård med fokus på påverkan från privata aktörer övervägdes. Ett sådant fokus kan belysa interorganisatoriska

spänningar, men en tvåfallsstudie bedömdes ge större empiriskt djup och teoretisk kontrast, vilket stärker analysens förklaringsvärde. Fallstudiedesign lämpar sig för kontextberoende fenomen där komplexa processer studeras snarare än kausala samband (Flyvbjerg, 2006). Implementering av strategisk personalstyrning är ett sådant fenomen, där organisatorisk praktik, professionell autonomi och styrlogik samverkar på sätt som kräver fördjupad, kontextkänslig analys. Det semistrukturerade formatet möjliggör även att forskaren kan följa upp intressanta utsagor samtidigt som alla deltagare får reflektera över kärnteman (Kvale & Brinkmann, 2014).

## 2.3 Urval av fall och respondenter

Fallurvalet sker enligt principer för strategiskt urval (Patton, 2015), där två former av vårdinrättningar representerar skilda institutionella logiker, offentliga sjukhus under regionens huvudmannaskap och privata vårdföretag inom Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Båda bedriver specialiserad somatisk vård av liknande medicinsk inriktning, vilket möjliggör jämförbar analys.

Urvalet av respondenter avgränsas till nyckelaktörer med strategisk insyn och ansvar för personalstyrning i form av HR-chefer, HR-strateger samt verksamhets- och mellanchefer med personalansvar. Denna avgränsning motiveras av studiens fokus på organisatoriska och ledningsrelaterade aspekter av strategisk personalstyrning, snarare än professionsspecifika eller kliniska perspektiv. Begränsningen bidrar till analytisk precision och hanterbarhet, samtidigt som resurser och tidsramar styr urvalets omfattning.

Respondenterna bjöds in via mail där information om studiens omfattning, syfte och etiska ställningstagande redovisas, vilket finns tillgängligt i bilaga 1. Det förväntade antalet intervjuer per form av inrättning var 3–6, vilket bedömdes tillräckligt för att uppnå teoretisk mättnad (Guest, Bunce & Johnson, 2006; Saunders, Lewis & Thornhill, 2023). Slutliga utfallet blev dock att 4 respondenter från respektive form av inrättning deltog i studien.

## 2.4 Datainsamling

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, där en intervjuguide utvecklas utifrån studiens syfte och teoretiska referensram. Intervjuerna fokuserar på centrala teman som HR-funktionens roll och inflytande, upplevda hinder för strategisk personalstyrning, professionell autonomi, interaktion mellan ledning och personal samt implementering av HR-initiativ i praktiken och redovisas i bilaga 2. Intervjuerna spelas in med informerat samtycke när möjligt och transkriberas i sin helhet för att säkerställa detaljerad och korrekt data. Detta säkerställer datakvalitet samtidigt som praktiska och etiska krav respekteras.

## 2.5 Dataanalys

Dataanalysen genomfördes med tematisk analys i enlighet med Braun och Clarke (2006) där analysen följer sex steg:

1. Bekantskap med data – Upprepad läsning av transkriberat material och initiala anteckningar.

2. Generering av initiala koder – Systematisk kodning av meningsbärande enheter.

3. Sökning efter teman – Gruppering av relaterade koder till preliminära teman.

4. Granskning av teman – Teman revideras för tydlighet och konsistens.

5. Definition och benämning av teman – Teman får tydliga, beskrivande namn.

6. Rapportering – Teman analyseras i relation till forskningsfrågor och teoretisk referensram.

Analysen är iterativ och abduktiv, där teori och empiri samverkar, empiriska fynd relateras kontinuerligt till teoretiska begrepp för att förstå underliggande mekanismer (Dubois & Gadde, 2002; Maxwell, 2013). En jämförande analys mellan offentligt och privat genomförs för att identifiera likheter samt skillnader och teman tolkas med stöd av kritisk realism (Sayer, 2000; Danermark et al., 2002). Analysen genomfördes med kvalitativ analysmjukvara (NVivo15) för att underlätta struktur, transparens och spårbarhet (Nowell et al., 2017).

## 2.6 Forskningsetiska överväganden

Forskaren är det huvudsakliga analysinstrumentet i en kvalitativ studie, vilket gör reflexivitet central (Malterud, 2001). Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017), med fokus på:

- Informerat samtycke från deltagare

- Anonymisering av person- och organisationsuppgifter

- Säkert lagrad data enligt GDPR

- Transparens kring syfte, användning och rapportering av data

## 2.7 Metodkritik och begränsningar

Studien bygger på en kvalitativ fallstudiedesign som är kontextbunden, vilket innebär att resultat och slutsatser har begränsad generaliserbarhet till andra vårdorganisationer eller nationella kontexter. Den komparativa ansatsen bidrar dock till analytisk generalisering genom att identifiera mönster och skillnader mellan två olika driftsformer, vilket kan potentiellt ge insikt i underliggande mekanismer i liknande organisatoriska sammanhang.

En central metodologisk utmaning är risken för forskarens subjektiva påverkan, ofta kallad forskarkontamination. Genom tidigare erfarenheter och förförståelse påverkas omedvetet tolkningen av empiriskt material. För att minska denna påverkan hanteras reflexivitet aktivt genom kontinuerlig självgranskning, systematisk dokumentation av analytiska val och antaganden samt dialog med handledare och medbedömare. Genom medvetenhet om riskerna ämnas transparens prioriteras, även om fullständig objektivitet aldrig kan uppnås i kvalitativ forskning.

Ytterligare begränsningar avser urval och datainsamling där det snäva urvalet av nyckelaktörer, tidsbegränsning samt begränsade möjligheter att få andra perspektiv från medforskare kan påverka datans bredd och djup. Dessa faktorer behöver beaktas vid tolkningen av resultat och eventuella försök att överföra slutsatser till andra organisatoriska kontexter.

# 3 Teoretisk referensram

*Kapitlet presenterar den teoretiska referensramen för studien och belyser implementeringen av SHRM inom hälso- och sjukvården med fokus på organisatoriska och professionella barriärer, HR:s strategiska roll, legitimitet, samverkan och ledarskap, samt hur skillnader mellan offentlig och privat sektor potentiellt inverkar på förutsättning för implementering.*

## 3.1 Professionell autonomi och kulturella barriärer

Implementeringen av strategisk personalstyrning (SHRM) inom hälso- och sjukvården är nära sammankopplad med organisationens interna strukturer, HR-funktionens position samt det professionella landskapet (Wright & McMahan, 2011). För att förstå vilka hinder och möjligheter som påverkar SHRM i vårdkontext krävs en analys av både organisatoriska och professionella dimensioner, samt de strategiska mekanismer som kan överbrygga dessa barriärer (Brewster, Chung & Sparrow, 2016).

En central utmaning inom hälso- och sjukvården är den professionella autonomin hos kliniska yrkesgrupper. Läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner har starka yrkesidentiteter och normativa värderingar som kan stå i konflikt med organisatoriska strategier (Polder & Jochemsen, 2000; Noordegraaf, 2015). Strategier som uppfattas som top-down eller administrativt styrda kan mötas av motstånd, passivitet eller selektivt genomförande (Spehar, Frich & Kjekshus, 2015). Professionslogik är avgörande för förståelsen av hur SHRM-mekanismer tolkas i vårdorganisationer. Framgångsrik implementering kräver att strategier anpassas till professionernas normer och prioriteringar (Kirkpatrick & Ackroyd, 2003; Noordegraaf, 2015).

Tidigare studier visar att en stark betoning på kontroll kan upplevas som ett hot mot professionell autonomi och leda till låg motivation och negativ inställning till förändring (Cogin, Ng & Lee, 2016). Vidare pekar Gile, van de Klundert och Buljac-Samardzic (2022) på att även om formella HRM-policyer finns, upplevs de ofta som irrelevanta i praktiken, vilket minskar deras genomslagskraft. Detta understryker vikten av att arbeta med professionernas uppfattningar och autonomi, snarare än att enbart styra genom administrativa verktyg.

## 3.2 Organisatoriska barriärer för implementering

Implementeringen av SHRM påverkas starkt av HR-funktionens position i organisationens styrkedja. En återkommande utmaning är att HR reduceras till en administrativ stödfunktion med begränsat strategiskt inflytande, vilket skapar ett glapp mellan personalstyrning och organisationens övergripande mål (Wright & Nishii, 2007; Townsend, Wilkinson & Allan, 2013). Detta underminerar förutsättningarna för långsiktiga och hållbara förändringsprocesser och begränsar integrationen av HR-strategier i kärnverksamheten (Paauwe, 2009; Brewster, Chung & Sparrow, 2016).

Hälso- och sjukvårdens interna strukturer präglas ofta av hierarkier och fragmentering, vilket skapar barriärer för samordning mellan olika nivåer och funktioner (Fitzgerald et al., 2002; Ferlie et al., 2013). Tidigare studier visar att HR-funktionen ofta domineras av transaktionella rutiner och beteendestyrda processer snarare än strategiskt drivande initiativ, vilket begränsar HR:s potential att bidra till organisatorisk utveckling (Cogin, Ng & Lee, 2016). Externa faktorer utgör ytterligare hinder där statliga regelverk och obligatoriska policyer kan begränsa handlingsutrymmet, särskilt i resursbegränsade miljöer, vilket fungerar som strukturella barriärer för implementering av strategiska personalstrategier (Gile, van de Klundert & Buljac-Samardzic, 2022).

Moderna SHRM-teorier framhåller att HR bör fungera som strategisk partner snarare än enbart administrativ funktion (Ulrich, 1997; Becker & Huselid, 2006). Det innebär att HR inte endast ska hantera operativa processer som rekrytering och administration, utan även aktivt bidra till formulering och genomförande av organisationens långsiktiga mål. Forskning indikerar att när HR får mandat att agera strategiskt, men fortfarande begränsas av centraliserade strukturer, uppstår spänningar mellan organisatoriska mål och lokal anpassning (Rees & Smith, 2021).

Tidigare forskning visar även att integrering av HR-praktiker med både finansiella och icke-finansiella incitament, i kombination med engagerat ledarskap, kan leda till förbättrad personalnöjdhet och prestation, även i resursbegränsade miljöer (Gile, van de Klundert & Buljac-Samardzic, 2022). Detta understryker att strategisk personalstyrning är möjlig, men beroende av att HR ges tillräckligt inflytande och handlingsutrymme.

## 3.3 Legitimitet, samverkan och strategiskt ledarskap

Implementering av strategisk personalstyrning i professionellt dominerade organisationer som hälso- och sjukvården förutsätter mekanismer som stärker legitimitet, samverkan och strategiskt ledarskap (Welker et al., 2014). Dessa mekanismer behövs för att överbrygga de barriärer som uppstår när organisatoriska krav möter professionella normer och etablerade arbetssätt (Rotea et al., 2023).

HR-praktiker fungerar här som gränsroller som navigerar mellan administrativa mål och professionella identiteter. Deras möjlighet att påverka implementeringen är beroende av både formell och informell makt, samt av den legitimitet de lyckas etablera gentemot kliniska professioner (Greenhalgh et al., 2004). Legitimitet anses byggas genom dialog, relationsskapande och förståelse för professionernas villkor, vilket ökar mottagligheten för strategiska initiativ (Swanwick & McKimm, 2017).

Samverkan och kommunikativt ledarskap har lyfts som centrala mekanismer för att skapa engagemang och minska motstånd, särskilt i miljöer där professionell autonomi är stark (Cogin, Ng & Lee, 2016). Däremot tenderar mer kontrollorienterade och standardiserade strategier att möta större professionellt motstånd (Rees & Smith, 2021). Sammantaget visar teorin att HR:s inflytande över implementeringen av strategisk personalstyrning formas av de legitimitets-, samverkans- och maktrelationer som präglar hälso- och sjukvårdens organisatoriska och professionella landskap.

## 3.4 Kontextuella skillnader mellan privat och offentlig vård

Huvudmannaskap ter sig ha en viss inverkan på implementeringen av SHRM då offentliga vårdorganisationer präglas av komplexa byråkratiska strukturer, stark reglering och formaliserade beslutsvägar, vilket begränsar flexibiliteten i HR-arbetet (Boyne, 2002; Ferlie et al., 2013; Lægreid & Rykkja, 2015). I sådana miljöer kan organisatoriska barriärer bli mer uttalade och implementering av strategiska personalstrategier fördröjas eller begränsas.

Privata vårdgivare tenderar att ha ett aningen större handlingsutrymme och kan anpassa HR-strategier mer flexibelt efter affärsbehov och lokal kontext (Gile, Buljac-Samardzic & Klundert, 2018). Detta möjliggör snabbare implementering och marknadsorienterad kultur, men ställer HR inför utmaningen att balansera vinstkrav med professionella värderingar och legitimitet (Soni & Sharma, 2024).

Vidare hanteras professionell autonomi till viss del olika beroende på sektor, där privata aktörer ibland kan erbjuda mer lokalt inflytande men också ställa större krav på individuellt ansvarstagande (Ferlie et al., 2013; Noordegraaf, 2015). Sammanfattningsvis påverkas organisatoriska och professionella barriärer av sektor, styrning och huvudmannaskap. En förståelse för dessa kontextuella skillnader är central för utformning av effektiva och relevanta HR-strategier i både offentlig och privat vård.

## 3.5 Teoretisk förankring av intervjuteman

Temana inom intervjuguiden är teoretiskt förankrade i forskning om implementering av SHRM inom professionellt dominerade organisationer. Tidigare studier visar att SHRM påverkas av såväl organisatoriska strukturer och styrmodeller som professionella logiker, normer och strategiska mekanismer som möjliggör implementering i komplexa vårdorganisationer (Wright & McMahan, 2011; Brewster, Chung & Sparrow, 2016). Mot denna bakgrund utgör fyra övergripande teman ramen för intervjuguiden.

Temat organisatoriska hinder grundas i forskning som belyser HR-funktionens begränsade strategiska inflytande i hierarkiska och fragmenterade organisationer, samt hur styrmodeller och externa krav påverkar möjligheterna till långsiktigt strategiskt HR-arbete (Townsend, Lawrence & Wilkinson, 2013; Ferlie et al., 2013). Samtidigt motiveras temat professionella hinder av studier som visar att stark yrkesautonomi, normativa värderingar och professionslogiker kan påverka hur personalstrategiska initiativ tolkas och implementeras i praktiken (Kirkpatrick & Ackroyd, 2003; Noordegraaf, 2015).

Temat strategiska mekanismer baseras på forskning som framhåller betydelsen av legitimitet, samverkan och kommunikativt ledarskap för att överbrygga spänningar mellan organisatoriska mål och professionella normer (Greenhalgh et al., 2004; Cogin, Ng & Lee, 2016). Slutligen motiveras temat kontextuella skillnader av studier som visar att sektor, huvudmannaskap och institutionella kontexter påverkar både organisatoriska förutsättningar och professionella föreställningar kring HR-arbete (Boyne, 2002; Lægreid & Rykkja, 2015).

Intervjuguiden är således utformad för att systematiskt fånga centrala teman i empiriskt material, vilket säkerställer att studien adresserar både organisatoriska, professionella och kontextuella aspekter av SHRM. Den teoretiska förankringen av temana ämnar därmed skapa en länk mellan litteratur, intervjufrågor och den efterföljande analysen.

# 4 Empiri

*Kapitlet redogör studiens empiriska material erhållet från semistrukturerade intervjuer med respondenter inom offentlig samt privat vård. Materialet är strukturerat kring teman från intervjuguiden och presenterar variationer och likheter mellan sektorerna. Kapitlet inleds med en redogörelse över deltagarnas bakgrund, följt av tematiserade avsnitt kopplade till centrala observationer.*

## 4.1 Respondenter och datamaterial

Det empiriska materialet i denna studie består av åtta semistrukturerade intervjuer med nyckelaktörer inom två former av vårdinrättningar som representerar olika institutionella logiker, offentliga sjukhus under regionens huvudmannaskap och privata vårdföretag inom LOV-systemet. Urvalet av respondenter har skett strategiskt (Patton, 2015), med fokus på personer med strategisk insyn och ansvar för personalstyrning, såsom HR-chefer, HR-strateger samt verksamhetschefer med personalansvar.

Denna avgränsning motiveras av studiens fokus på organisatoriska och ledningsrelaterade aspekter av strategisk personalstyrning, snarare än kliniska perspektiv, och syftar till att uppnå analytisk precision och hanterbarhet. Tabell 1 nedan ger en översikt över respondenterna, deras sektor, roll och arbetslivserfarenhet. Mer detaljerad information om deras bakgrund, utbildning, erfarenheter och särskilda ansvarsområden finns i bilaga 3.

**Tabell 1:** Översikt över respondenter

| *Kod* | *Sektor* | *Roll/titel* | *Arbetslivserfarenhet (år)* |
|---|---|---|---|
| *O1* | Offentlig | HR-partner | 11 år (8 år nuvarande, 3 år privat) |
| *O2* | Offentlig | HR-koordinator | ~1 år |
| *O3* | Offentlig | HR-partner | 4 år<br>(samt >10 år som sjuksköterska) |
| *O4* | Offentlig | HR-koordinator | ~1 år |
| *P1* | Privat | HR Business Partner | 5 år<br>(samt tidigare erfarenhet vid annan vårdinrättning) |
| *P2* | Privat | HR-direktör | ~7 år<br>(samt internationell erfarenhet inom privat vård) |
| *P3* | Privat | Head of People & Organization | 3 år<br>(samt internationell erfarenhet inom healthtech, försäkringsmedicin och privata vårdgivare) |
| *P4* | Privat | HR-specialist | ~3 år |

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide utvecklad utifrån studiens syfte och teoretiska referensram. Intervjuerna fokuserade på teman som HR-funktionens roll och inflytande, upplevda hinder för strategisk personalstyrning, professionell autonomi, interaktion mellan ledning och personal samt implementering av HR-initiativ i praktiken. Samtliga intervjuer spelades in med informerat samtycke som angivits i inbjudan och transkriberades i sin helhet för att säkerställa korrekt och detaljerad data. Efter genomförande av intervjuerna transkriberades materialet för att kodas utifrån kodningsschemat i bilaga 4.

## 4.2 Kontextuella skillnader

### 4.2.1 Styrningslogik och beslutsprocesser

Respondenter beskriver vissa skillnader i styrningslogik mellan offentlig och privat sjukvård, där offentlig sektor präglas av omfattande regelverk, formella processer och flera beslutsnivåer, vilket påverkar både beslutsfattande och handlingsutrymme. Beslutsprocesserna upplevs ofta som långsamma och komplexa. En respondent uttrycker att ”beslutsprocesserna är mer komplexa och det kan ta längre tid att få igenom förändringar” (O1), medan en annan beskriver organisationen som ”ganska hierarkisk och regelstyrd, vilket gör det svårt för HR att agera proaktivt” (O2).

Flera respondenter lyfter även fram den politiska styrningen som en central del av den offentliga kontexten där prioriteringar kan förändras snabbt, vilket påverkar möjligheten att arbeta långsiktigt. Som O3 uttrycker det där ”prioriteringarna kan svänga snabbt, vilket gör det svårt att hålla i långsiktiga satsningar”. Beslut behöver ofta förankras på flera nivåer och dokumenteras noggrant, vilket enligt O4 innebär att ”besluten måste gå igenom många nivåer innan vi kan agera”.

I privat sektor beskrivs styrningslogiken i större utsträckning som flexibel och resultatorienterad där beslutsvägarna upplevs som kortare, vilket möjliggör snabbare agerande. En respondent beskriver att ”i privat sektor är beslutsvägarna mycket snabbare och mer resultatorienterade – man kan fatta beslut och sätta saker i rullning på några dagar” (P1). Denna struktur ger HR och chefer större mandat att fatta beslut och anpassa insatser efter verksamhetens behov.

### 4.2.2 Position och grundläggande uppdrag

I offentlig sektor beskrivs HR:s position frekvent som rådgivande och stödjande där HR involveras sent i många beslutsprocesser, ofta när ramarna redan är satta. O3 beskriver detta som att ”*man ofta hamnar i en rådgivande roll när besluten redan är på gång*”. HR:s arbete präglas i hög grad av efterlevnad, riskhantering och dokumentation. Som P1 uttrycker blir offentlig sektor ”*det blir mer av en garant för att regler och processer följs”*. Samtidigt framhålls denna roll som viktig för att säkerställa rättssäkerhet, transparens och likabehandling inom organisationen.

I privat sektor beskrivs HR:s roll som mer integrerad i verksamhetens strategiska arbete och affärsmodell där HR ofta är delaktig i ledningsnära beslutsfattande och arbetar aktivt med uppföljning av HR-initiativ genom mätbara indikatorer. En respondent beskriver att HR är ”*mycket mer integrerat i affärsstrategin*” (P1), medan en annan lyfter vikten av att ”*alla beslut måste kunna motiveras med siffror, resultat och påverkan på verksamheten*” (P2). Samtidigt betonas behovet av balans mellan snabbhet och långsiktighet, där HR förväntas hantera både operativa krav och strategiska mål.

### 4.2.3 Organisatoriska strukturer och hinder

Respondenterna beskriver organisatoriska strukturer som en central faktor som påverkar HR:s handlingsutrymme och möjligheten att agera strategiskt, med tydliga skillnader mellan offentlig och privat sektor. I offentlig sektor framhålls framför allt hög centralisering och komplexa hierarkier som hinder för proaktivt HR-arbete. Respondent O2 beskriver att "*beslut tas väldigt långt från verksamheten, och det gör att vi inte alltid kan agera när behovet uppstår*", medan O3 lyfter att lokala initiativ ofta måste förankras på flera nivåer där "*det finns en process för allt, och även små saker måste upp för beslut i någon form av ledningsgrupp*". Denna struktur anses leda till långsammare beslutsprocesser och att HR ofta får agera mer reaktivt än strategiskt.

Flera respondenter menar att centralisering gör HR till "utförare snarare än utvecklare" som O1 lyfter det och att strategiska initiativ ofta riskerar att hamna på undantag eftersom de måste anpassas till redan fattade beslut. Här lyfter respondent O1 att "Det innebär att vi inte kan ta fram initiativ på egen hand utan måste alltid förankra oss i de övergripande besluten".

Hierarkier och organisatorisk fragmentering upplevs också som begränsande. Respondent O4 framhåller att organisationen är "så pass uppdelad att HR ibland hamnar mellan stolarna – man måste förhålla sig till flera nivåer samtidigt", och O3 beskriver att "HR kommer ofta inte med i de allra tidigaste diskussionerna, utan inblandning sker när besluten redan börjat ta form". Fragmentering mellan administrativa funktioner, kliniska verksamheter och ledningsnivåer gör det svårt att driva enhetliga strategiska initiativ, och resurser går ofta åt till akuta operativa behov enligt O3 där "Vi har expertrollen men inte alltid mandatet… när man hela tiden måste hantera akuta personalärenden blir det svårt att arbeta långsiktigt och strategiskt".

Formell position och ansvarsfördelning påverkar HR:s strategiska kapacitet ytterligare där O1 uttrycker att "*vi sitter inte alltid med när de tidiga besluten fattas, och då blir vårt arbete mer reaktivt*". Samtidigt menar O2 att "*ibland är det oklart vem som ska göra vad*", något som förekommer särskilt i gränslandet mellan HR och linjechefer. Detta upplevs av respondenterna skapa risk för inkonsekvent genomförande och att initiativ faller mellan stolarna. Även i privat sektor kan mandat och ansvarsfördelning påverka HR:s möjligheter då P3 menar att "*vi har större möjligheter att agera, men det är fortfarande cheferna som sitter på mycket av beslutsmakten*".

Resursbegränsningar och administrativa krav beskrivs som ytterligare hinder då O3 menar att "*Det är inte viljan som saknas, utan tiden. Det är alltid något akut som går före*", medan O4 konstaterar: "*Vi fastnar lätt i administration… vi måste rapportera mycket, och det tar fokus från utvecklingsarbetet*". Även i privata organisationer upplevs administrativa krav bromsa förändring där P2 anger att *"Även om vi ser att något behöver förändras… måste vi först klara alla administrativa krav innan vi kan ta tag i själva förändringen"*. Sammantaget upplevs dessa faktorer leda till att HR ofta prioriterar operativa behov framför långsiktiga strategiska mål.

### 4.2.4 Profesionell logik och kliniska normer

Intervjuerna tyder på att professionell logik och yrkesnormer inom kliniken påverkar hur HR:s initiativ tas emot och implementeras. Vissa medarbetare, särskilt läkare, har svårt att se nyttan av HR:s satsningar i en pressad vardag där O1 beskriver detta som att *"vissa strategiska initiativ upplevs som något som läggs 'ovanpå' det dagliga arbetet…"*. Hög autonomi hos läkare och specialistsjuksköterskor påverkar uppfattningen av HR-initiativ, som ibland ses som styrande eller administrativt. O2 beskriver det som "*Bromsklossarna*

*är ofta yrkesgrupper med hög arbetsbelastning eller med stark tradition av autonomt beslutsfattande”*.

O4 menar att HR:s rekommendationer ofta får ge vika för verksamhetens omedelbara behov då “*HR kan presentera argument, statistik och rekommendationer, men klinikerna prioriterar ofta patientflödet framför HR:s förslag*”. P1 lyfter kulturen inom vården som ett hinder *“Bromsarna är ofta högspecialiserade kliniker där scheman är pressade… Även vissa seniora läkare kan vara motvilliga…”*. Samtidigt kan engagerade kliniker fungera som ambassadörer där O1 också påpekar att *“Arbetar i team, följer strukturer och rutiner… Därför är de ofta mer mottagliga för HR:s arbete…”*.

Uppfattningen av HR som administrativ funktion framträder tydligt då O1 beskriver att “Det kan handla om att man upplever en förändring som ytterligare administration, eller som något som kommer ‘ovanifrån’ utan tydlig koppling till det man själv gör…”. O2 menar att “Vissa läkare vara svåra att engagera, ofta på grund av vana vid hög autonomi och skepsis mot det som upplevs som ‘administrativa’ initiativ”. P2 beskriver att specialistläkare ibland uppfattar HR-initiativ som tvång där “Vissa specialistläkare upplevde det som ett ‘administrativt tvång. De menade att deras tid borde ägnas åt kliniskt arbete eller forskning, inte schemalagda moduler”.

Inom privat sektor framhålls vikten av koppling till vardagen för engagemang. P4 uttryckte det som “Generellt är det alltid lättare att engagera personal som ser en tydlig koppling till sin egen vardag, till exempel utvecklingsmöjligheter, bättre arbetsförhållanden eller mer balans mellan arbete och fritid”. Om styrande verktyg upplevs som irrelevanta kan de ifrågasättas enligt P4 då “De vill själva ha kontroll över hur de planerar sin tid, prioriterar uppgifter och organiserar sitt arbete. HR:s styrande verktyg… möts ibland med frågor om relevans och värde”.

## 4.3 Organisatoriska hinder för strategiskt arbete

### 4.3.1 Struktur och ansvarsfördelning

Respondenter beskriver att centralisering ofta minskar HR:s flexibilitet och möjligheten att anpassa initiativ efter lokala behov. I offentlig sektor lyfter O2 fram att ”beslut tas väldigt långt från verksamheten, och det gör att vi inte alltid kan agera när behovet uppstår”. O3 poängterar att lokala initiativ ofta måste förankras på flera nivåer då ”det finns en process för allt, och även små saker måste upp för beslut i någon form av ledningsgrupp”. O1 beskriver att detta leder till att HR blir mer operativt än strategiskt där ”man blir mer utförare än utvecklare när allt är så styrt uppifrån”.

Hierarkiska strukturer och organisatorisk fragmentering upplevs förstärka dessa begränsningar då O4 uttrycker att ”så pass uppdelad att HR ibland hamnar mellan stolarna – man måste förhålla sig till flera nivåer samtidigt”. Fragmenteringen påverkar inte bara beslutsflöden utan även möjligheten att implementera strategiska initiativ konsekvent då O3 konstaterar att ”HR kommer ofta inte med i de allra tidigaste diskussionerna, utan inblandning sker när besluten redan börjat ta form”.

Formell position och ansvarsfördelning är ytterligare faktorer där O2 lyfter fram att otydliga roller skapar osäkerhet då ”ibland är det oklart vem som ska göra vad, särskilt i gränslandet mellan HR och chef”. O3 menar att detta ofta gör HR mer reaktivt genom att ”i praktiken hamnar man mer i en rådgivande roll när besluten redan är på gång”.

I privat sektor är centralisering och hierarki generellt mindre begränsande enligt respondenterna där P1 beskriver att ”Koncernens riktlinjer gäller, men vi kan fatta många

beslut lokalt", vilket upplevs ge HR större handlingsutrymme. P3 framhåller att tydlig ansvarsfördelning underlättar implementeringen av strategiska initiativ då "När alla vet vem som gör vad rullar initiativ ut effektivt, men annars riskerar saker att fastna". Även om strukturella hinder finns i privat sektor upplevs deras påverkan mindre drastisk än i offentlig sektor enligt respondenterna.

### 4.3.2 Resurser och administrativa krav

Brist på tid, personal och omfattande administrativa krav framstår som betydande hinder för strategiskt HR-arbete då O3 beskriver det som att *"Det är inte viljan som saknas, utan tiden. Det är alltid något akut som går före"*. O4 betonar den administrativa bördan där *"Vi fastnar lätt i administration… vi måste rapportera mycket, och det tar fokus från utvecklingsarbetet".* O1 menar att detta gör att HR i praktiken prioriterar dagliga problem framför långsiktiga mål då *"Vi hanterar dagliga problem och får svårt att tänka långsiktigt".*

I privat sektor upplevs HR:s handlingsutrymme som större, men administrativa krav kan ändå bromsa förändring. P2 noterar att "Även om vi ser att något behöver förändras… måste vi först klara alla administrativa krav innan vi kan ta tag i själva förändringen". P1 beskriver att detta kan leda till en mer administrativ än strategisk roll då "Ibland känns det som att vi är mer en administrativ enhet än en strategisk partner".

Sammanvägt upplever respondenterna att organisatoriska hinder som centralisering, hierarkier, otydliga roller, resursbrist och administrativa krav påverkar HR:s strategiska kapacitet. Offentlig sektor påverkas mest, med långsamma beslutsprocesser, begränsat mandat och större fragmentering, vilket O2 anger genom "Beslut tas väldigt långt från verksamheten, och det gör att vi inte alltid kan agera när behovet uppstår".

Privat sektor upplevs av respondenterna ha större flexibilitet och kortare beslutsvägar men fortfarande påverkas av riktlinjer och administrativa krav då P1 anser att "Beslutsvägarna är kortare i den privata sektorn, men där finns ändå riktlinjer och processer som påverkar vårt handlingsutrymme". Dessa organisatoriska faktorer upplevs betydande för hur HR kan implementera strategiska personalinitiativ och realisera SHRM i praktiken.

## 4.4 Professionella hinder för strategiskt arbete

### 4.4.1 Klinisk logik och dess inverkan

Respondenterna beskriver att skillnader mellan klinikernas vardag och HR:s strategiska initiativ kan skapa hinder för implementering. I offentlig sektor upplever O1 att *"vissa strategiska initiativ upplevs som något som läggs 'ovanpå' det dagliga arbetet"*, medan O2 framhåller att *"bromsklossarna är ofta yrkesgrupper med hög arbetsbelastning eller med stark tradition av autonomt beslutsfattande"*. O4 menar att HR:s rekommendationer ofta måste ge vika för verksamhetens omedelbara behov då *"HR kan presentera argument, statistik och rekommendationer, men klinikerna prioriterar ofta patientflödet framför HR:s förslag".*

I privat sektor noterar P1 att arbetsbelastningen fortfarande påverkar mottagandet av HR-initiativ där *"Även om vi är snabbare så finns det områden vi inte rör utan godkännande".* P3 framhåller att initiativ som kopplas till verksamhetsnytta ofta får bättre genomslag då *"Initiativ som kopplas till KPI:er, ekonomi eller patientutfall får bättre fäste, medan mer 'mjuka' initiativ kan tappa fart utan kontinuerlig uppföljning och ledningsengagemang".*

Respondenter beskriver även att begränsade resurser påverkar implementeringen där O3 säger att ”Många avdelningar arbetar redan på marginalen vad gäller bemanning, vilket innebär att även om intentionerna är positiva finns inte alltid tid eller resurser att delta”, och O1 betonar tidsbristens betydelse eftersom ”Det är inte viljan som saknas, utan tiden. Det är alltid något akut som går före”.

### 4.4.2 Professionsnormer och yrkesidentitet

Respondenterna lyfter att professionslogik och yrkesidentitet är centrala för hur HR-initiativ tas emot. O2 beskriver att ”professioner som läkare och specialistsjuksköterskor är vana vid att fatta egna beslut inom sina områden, och HR-strategier som känns styrande kan uppfattas som påtvingade”. O3 uppger att seniora läkare ofta är mer motvilliga till förändring då ”Erfarenhet och senioritet påverkar i hög grad hur initiativ tas emot, där yngre eller administrativ personal oftare är mer mottagliga”.

O4 framhåller teamdynamikens betydelse eftersom ”*Engagerade medarbetare kan fungera som ambassadörer, medan de som har stark autonomi kan bromsa förändring*”. I privat sektor framhåller P2 att initiativ som tydligt kopplas till arbetsuppgifter tas emot bättre då ”*Generellt är det alltid lättare att engagera personal som ser en tydlig koppling till sin egen vardag, till exempel utvecklingsmöjligheter, bättre arbetsförhållanden eller mer balans mellan arbete och fritid*”. P4 beskriver opinionsbildares roll då det ”*I vissa fall har vi också involverat opinionsbildare inom professionerna för att säkerställa legitimitet och acceptans*”.

### 4.4.3 Uppfattning som administrativ funktion

Respondenter beskriver att HR ofta uppfattas som administrativt snarare än strategiskt. O1 säger att ”Det kan handla om att man upplever en förändring som ytterligare administration, eller som något som kommer ‘ovanifrån’ utan tydlig koppling till det man själv gör”. O2 betonar att vissa läkare kan vara skeptiska där ”Vissa läkare är svåra att engagera, ofta på grund av vana vid hög autonomi och skepsis mot det som upplevs som ‘administrativa’ initiativ”. O3 påpekar att HR ofta ses som något ”vid sidan av kärnverksamheten, nästan som en administrativ funktion snarare än en strategisk partner”.

I privat sektor framhålls däremot vikten av relevans för engagemang där P3 beskriver att ”*Om HR:s strategier upplevs som påtvingade kan det skapa motstånd, passivitet eller i värsta fall aktivt motspel*”. P4 menar att initiativ kopplade till vardagen tas emot bättre då ”*De vill själva ha kontroll över hur de planerar sin tid, prioriterar uppgifter och organiserar sitt arbete. HR:s styrande verktyg… möts ibland med frågor om relevans och värde*”. O4 noterar samtidigt att vissa processer generellt kan upplevas som tidskrävande oavsett sektor då ”*Vissa är mycket positiva och ser värdet i satsningarna, medan andra upplever att det tar tid från den operativa driften. Det kan kännas som ytterligare ett uppdrag på en redan tung arbetsbörda*”.

## 4.5 Strategiska mekanismer

### 4.5.1 Delaktighet och förankring

Återkommande tema i intervjuerna är betydelsen av tidig involvering och dialog i HR-initiativen där respondenterna beskriver delaktighet och förankring som centrala för att skapa engagemang och undvika motstånd i organisationen. Som O1 uttrycker det arbetar HR aktivt med att *”skapa utrymme för dialog”*, och enligt O3 ökar engagemanget när chefer och medarbetare *”får vara med från början, ge input och förstå varför förändringen behövs”.* Detta tyder på att förankring inte enbart handlar om

informationsspridning utan om att inkludera de aktörer som påverkas av förändringen i själva utformningen.

Betydelsen av förankring framkommer i både offentlig och privat sektor då P1 understryker att initiativ behöver vara *"förankrade hos de som ska göra jobbet"*, medan P2 beskriver hur HR använder dialogbaserade metoder som workshops, rundabordssamtal och digitala forum för att möjliggöra återkoppling. Flera respondenter lyfter också fram konkreta sätt att minska motstånd genom att ge professionerna reellt inflytande. O3 menar att motstånd kan minska när medarbetare *"själva anpassar delar av modellen"*, medan P3 betonar att pilotprojekt används för att *"bygga förtroende innan vi skalar upp"*. Intervjuerna visar också att interna ambassadörer utgör en central legitimerande kraft i förändringsarbetet. Enligt P4 sprids acceptansen snabbare när vissa nyckelpersoner visar stöd, och O2 framhåller att initiativ ofta *"behöver någon som driver… någon som är synlig och engagerad"*.

### 4.5.2 HR som strategisk partner

I både offentlig och privat sektor framträder HR:s roll som en strategisk partner som bidrar till att översätta övergripande mål till konkreta och hanterbara lösningar i verksamheten i varierande omfattning. HR deltar ofta i arbets- och styrgrupper där framtida kompetensbehov analyseras, kritiska yrkesroller identifieras och satsningar för rekrytering, utveckling och behållande av personal planeras. Enligt O1 behöver HR jobba mycket med att skapa förståelse för initiativ genom att *"Vi behöver skapa förståelse, översätta de övergripande målen till något konkret och hanterbart i chefens vardag, och samtidigt visa respekt för deras realiteter"*.

HR upplevs fungera som en bro mellan strategi och praktik, där analys och proaktiva initiativ är centrala. I offentlig sektor betonas mandat och representation i styrforum som möjliggör påverkan i tidiga faser av planering och beslut eftersom *"Att HR numera finns representerat i vissa ledningsforum gör stor skillnad – vi får möjlighet att lyfta personalfrågor tidigt i processen, inte bara i efterhand"* (O3). I privat sektor framhävs närheten till ledningen och tydliga kopplingar mellan HR-insatser och verksamhetens mål som avgörande för strategiskt genomslag där P2 lyfter att *"Koppla HR:s begrepp om utveckling, kompetens och kultur till professionernas egna värderingar om kvalitet, patientsäkerhet och evidens"*.

HR:s strategiska arbete beskrivs omfatta kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, kultur- och värdegrundsfrågor samt långsiktig personalplanering. Inom privat sektor lyfts detta av P3 som kopplat till övergripande organisation där *"Vi jobbar nära både affärs- och operationschefer för att se till att HR-initiativ faktiskt implementeras, men också med HR-teamet för att säkerställa att våra strategier får praktiskt genomslag i klinisk vardag"*.

Samtidigt är operativa uppgifter som rekrytering, introduktion och personaladministration fortfarande centrala och kan konkurrera med det strategiska arbetet. Detta framförs inom offentlig sektor av O4 som *"Drivande är ofta HR i samarbete med klinikchefer som har ett långsiktigt perspektiv på personalförsörjning. De ser tydligt kopplingen mellan stabila personalflöden och kvalitet i vården, och är därför beredda att investera tid och resurser"*. Denna balans hanteras genom att kombinera analytiska insikter med praktiskt stöd till chefer och kontinuerligt väga långsiktiga mål mot verksamhetens omedelbara behov.

### 4.5.3 Ledarskap och ambassadörer som drivkraft

Chefers engagemang upplevs påverka HR-funktionens möjligheter att verka strategiskt. O1 lyfter att *"Cheferna sätter verkligen tonen"* och O4 framhåller att implementering underlättas när HR-initiativ har tydlig koppling till verksamhetens mål då *"ledningens och chefernas engagemang är helt avgörande"*. Respondenterna framhåller att chefer fungerar som nyckelförmedlare för HR:s strategiska inflytande, både genom att själva delta aktivt och genom att signalera betydelsen av initiativen till medarbetarna.

Ambassadörer inom professionerna spelar en liknande roll för legitimitet där O4 beskriver att om en *"respekterad överläkare eller erfaren sjuksköterska ställer sig bakom ett initiativ, sprider det sig snabbt"*. I privat sektor betonas att program som visar konkreta förbättringar i arbetsflöden och patienthantering ofta blir *"nästan självdrivande*" (P3). Flera respondenter från båda sektorerna talar om *"change champions"* eller ambassadörer som *"föregår med gott exempel och inspirerar sina kollegor"*, vilket stärker engagemang och acceptans.

Vikten av att knyta HR-insatser till konkreta och mätbara resultat framhålls också. P2 förklarar att HR behöver kunna *"visa hur insatserna bidrar till kvalitet, effektivitet och patientupplevelse"*, medan P3 beskriver att "*när medarbetarna själva märker att det blir lättare att arbeta, bättre arbetsmiljö eller tydligare processer, blir det enklare att få med fler".*

### 4.5.4 Lokala anpassningar och balansering av strategi

Intervjuerna visar att HR arbetar med att översätta strategiska initiativ till lösningar som fungerar i olika verksamhetskontexter. O1 betonar vikten av att *"se helheten, men ändå förstå verksamhetens vardag på detaljnivå"*, och O3 beskriver HR som en brygga för att *"bygga bron mellan strategin och verkligheten".* Lokala behov kräver ibland kompromisser då O4 beskriver att kliniken ibland behöver prioritera bemanning trots HR:s långsiktiga bedömningar då *"Det kan vara frustrerande, men samtidigt realistiskt i en verksamhet där patienten alltid kommer först"*. P2 lyfter att modulbaserade utbildningar och ledarskapsprogram anpassas till lokala förutsättningar och karriärvägar.

Flexibilitet i scheman och arbetssätt är också viktiga, där P1 beskriver arbete med *"flexibla schemalösningar"* och P4 lyfter vikten av pilotupplägg där HR *"justerar utifrån feedback innan bredare införande"* Sammantaget visar intervjuerna att HR:s strategiska roll inte enbart handlar om övergripande initiativ utan i hög grad om förmågan att balansera strategi och operativa behov. Genom att utveckla lösningar som uppfattas som relevanta och genomförbara skapas långsiktig legitimitet och effekt i organisationen.

# 5 Analys

*Kapitlet analyserar empiriska resultat mot tidigare studier utifrån ett fokus på skillnader mellan offentlig och privat sjukvård i ett svenskt kontext. Utöver att belysa potentiella differenser och likheter så analyserar avsnittet tidigare forskning samt identifierar områden med bristande empiri rörande HR:s strategiska roll och förutsättningar.*

## 5.1 Övergripande skillnader

Intervjuerna visade på skillnader mellan hur SHRM implementeras i privat respektive offentlig sjukvård. För att ge en överskådlig bild av dessa skillnader har de empiriska resultaten organiserats utifrån fyra huvudteman. Som tabell 2 visar, är implementeringen i privat sektor generellt mer flexibel och affärsorienterad, medan offentlig sektor präglas av starkare reglering, byråkratiska strukturer och standardiserade processer.

**Tabell 2:** Jämförelse av implementering mellan privat och offentlig sjukvård

| TEMA | PRIVAT | OFFENTLIG |
|---|---|---|
| KONTEXTUELLA SKILLNADER | Flexibla och resultatorienterade organisationer med korta beslutsvägar. HR i viss mån integrerad i strategiska beslut, har större handlingsutrymme och initiativ upplevs relevanta för medarbetare. Relativt begränsade krav på administration. | Reglerade och hierarkiska organisationer med högre grad av politisk styrning, vilket gör beslutsprocesser långsammare. HR har ofta en rådgivande roll, arbetar med efterlevnad och dokumentation, och agerar ofta reaktivt. Hög autonomi hos kliniker och organisatorisk fragmentering gör implementering av HR-initiativ svårare |
| ORGANISATORISKA HINDER | Organisatoriska hinder är relativt små då HR har större handlingsutrymme tack vare lägre centralisering och hierarki, tydlig ansvarsfördelning och korta beslutsvägar. Administrativa krav upplevs fortsatt kunna bromsa strategiskt arbete. | HR begränsas av hög centralisering, komplexa hierarkier, fragmentering och otydliga roller, vilket gör att initiativ ofta blir reaktiva och administrativa krav prioriteras framför strategiskt arbete. |
| PROFESSIONELLA HINDER | Professionella hinder finns men är mindre starka då HR-initiativ tas emot bättre när de kopplas till vardag, arbetsuppgifter eller mätbara resultat, medan hög autonomi och arbetsbelastning fortfarande kan bromsa vissa strategiska satsningar. | HR påverkas starkt av klinikers autonomi, yrkeslogik och arbetsbelastning, vilket gör att initiativ ofta ses som påtvingade eller administrativa och prioriteras ned till förmån för patientflöde och operativa behov. |
| STRATEGISKA MEKANISMER | HR:s strategiska arbete underlättas av nära koppling till ledning, tydliga mål, lokala anpassningar och engagerade ambassadörer, vilket gör att initiativ kan genomföras snabbt och med praktiskt genomslag i verksamheten. | HR verkar strategiskt genom att skapa förankring, involvera chefer och ambassadörer samt anpassa initiativ efter lokala behov, men mandat och långsamma beslut begränsar ibland genomslaget och kräver större balans mellan strategi och operativa krav. |

## 5.2 Kontextuella skillnader i implementering

### 5.2.1 Styrningslogik, beslutsprocesser och organisatorisk tröghet

Empirin tyder på att styrningslogik och beslutsprocesser utgör centrala faktorer som skiljer offentlig och privat sjukvård när det gäller implementeringen av strategisk personalstyrning (SHRM). Likt det respondenterna återger så präglas offentlig sektor av politisk styrning, omfattande regelverk och hierarkiska beslutsstrukturer enligt både Christensen och Lægreid (2007) samt Boyne (2002), vilket resulterar i långa beslutsvägar och organisatorisk tröghet. HR-funktionen begränsas därmed ofta till reaktivt arbete och operativa uppgifter snarare än strategiskt partnerskap, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning om offentlig HRM (Ulrich & Dulebohn, 2015; Soni & Sharma, 2024).

Den politiska styrningen, i kombination med korta mandatperioder och skiftande prioriteringar, förstärker tröghet inom offentlig sektor genom att kontinuiteten i långsiktiga HR-strategier minskar, vilket både Boyne (2002) samt respondenterna återgett. Samtidigt stöds upplevelsen av långsamma beslutsvägar av teorier om SHRM, som framhåller att strategiskt HR-arbete kräver stabilitet och mandat för långsiktiga satsningar (Becker & Huselid, 2006; Wright & McMahan, 2011). I praktiken innebär detta att strategier ofta begränsas av att underordnas kortsiktiga politiska och administrativa krav, vilket begränsar möjligheten att realisera nyttobaserad vård och långsiktig kompetensförsörjning (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013; Lægreid & Rykkja, 2015).

Privata vårdorganisationer präglas däremot av en mer affärsdriven och resultatorienterad styrningslogik, med kortare beslutsvägar och större handlingsutrymme. Denna organisatoriska flexibilitet gör att HR kan agera strategiskt och anpassa personalstrategier till förändrade krav, vilket stärker HR:s roll som strategisk partner (Wright & McMahan, 2011; Boxall & Purcell, 2016). Det bidrar även till uppfattningen av privat vård som potentiellt mer flexibel, samt är enligt Boyne (2002) kanske den största skillnaden mellan sektorerna.

### 5.2.2 Organisatorisk position och handlingsutrymme

HR:s position i organisationens hierarki är enligt Brewster, Chung och Sparrow (2016) en avgörande determinant för implementeringen av SHRM. I offentlig sektor upplevs bland respondenterna HR ofta som en administrativ funktion med fokus på regelverk och dokumentation, vilket även Townsend, Wilkinson och Allan (2013) lyfter som begränsning för integreringen av HR-strategier med verksamhetens övergripande mål. Den sena involveringen i beslut och bristande mandat riskerar samtidigt underminera HR:s strategiska potential och försvårar långsiktigt organisatoriskt lärande (Lepak & Snell, 1999; Wright & McMahan, 2011).

I privata vårdorganisationer är HR däremot i högre grad integrerat i ledningens strategiska arbete och kopplat till ekonomiska och organisatoriska mål. Då medarbetare ses som strategiska resurser för konkurrensfördelar, så ges HR större legitimitet och möjlighet att påverka implementeringen (Barney, 1991; Becker & Huselid, 2006; Paauwe, 2009). Således kan positionen som HR besitter inom privat sektor agera mer proaktivt och situationsanpassat till verksamhetens krav i relation till offentlig sektor.

### 5.2.3 Lokala anpassningar och flexibilitet

Empirin indikerar att lokal autonomi är avgörande för HR:s strategiska genomslag, något som till viss del är vanligare inom privata vårdorganisationer. Då HR på enhetsnivå ges möjlighet att anpassa strategier för rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö efter lokala behov, möjliggörs snabbare och mer situationsanpassade insatser enligt Gile, van de Klundert och Buljac-Samardzic (2022) samt Paauwe (2009).

Denna flexibilitet står i kontrast till den offentliga sektorn, där politiska cykler och formaliserade strukturer upplevs begränsa kontinuiteten i HR-strategiska satsningar. Samtidigt pekar litteraturen i form av Lepak och Snell (1999), Boyne (2002) samt Barney (1991) på risker med överdriven kortsiktighet inom privata organisationer, där fokus på snabba resultat kan undergräva långsiktiga investeringar i kompetens och organisatorisk hållbarhet. Således kan lokala anpassningar fungera som en strategisk resurs i linje med respondenternas upplevelser, men det bör förekomma en balans mellan långsiktighet och kortsiktighet oavsett sektor.

## 5.3 Organisatoriska faktorers inverkan

### 5.3.1 Proffesioner som hinder

Professionell autonomi upplevs utgöra en central barriär för implementeringen av SHRM i båda sektorerna. I offentlig sektor är läkare och specialistsjuksköterskor starkt förankrade i kliniska normer, vilket gör att administrativa HR-initiativ ofta upplevs som påtvingade och nedprioriteras till förmån för patientnära arbete. Detta bekräftar professionsforskning som betonar att starka yrkeslogiker kan motverka organisatoriska styrningsinitiativ (Freidson, 2001; Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013; Noordegraaf, 2015). HR:s legitimitet blir i detta sammanhang beroende av hur väl initiativen upplevs förenliga med professionella normer och yrkesutövning.

I privata vårdorganisationer förekommer samtidigt liknande professionella spänningar, men HR-initiativ accepteras oftare om de upplevs som kliniskt relevanta eller när nytta kan konkretiseras i mätbara resultat. Teorier om legitimitet och institutionell anpassning understryker att HR:s genomslag är beroende av överensstämmelse med professionella normer och lokala behov (Paauwe, 2009; Boxall & Purcell, 2016; Swanwick & McKimm, 2017).

Således är det möjligen en begränsad kontextuell skillnad mellan sektorerna när det kommer till att arbeta med kliniker och olika former av professioner. Samtidigt kan privat sektors större möjlighet till flexibilitet bidra till att bättre hantera personalen genom reducerad detaljstyrning, som anges av Cogin, Ng och Lee (2016). Alternativt kan privat sektor vara bättre lämpad till att hantera professioners autonomi till följd av mindre organisationer samt tydligare kommunikation från ledningen när omfattningen på verksamheten är mindre, faktorer som Glenngård och Malmi (2025) lyfte var relevanta för både privat och offentlig vård i ett svenskt kontext.

### 5.3.2 Organisatorisk flexibilitet

Samtidigt framhåller empirin att lokal autonomi innebär en balansgång mellan kortsiktiga resultat och långsiktiga investeringar i personal och organisatorisk hållbarhet. I privat sektor kan ett starkt fokus på snabba resultat riskera att långsiktiga kapaciteter och kompetensutveckling nedprioriteras, vilket lyfts av studier inom strategisk HRM (Barney, 1991; Lepak & Snell, 1999).

Offentlig sektor står inför motsvarande utmaning, men påverkas i stället av politiska cykler och byråkratiska processer som påverkar kontinuiteten i HR-strategier. En del av detta kan potentiellt vara kopplat till ambitioner om omfattande effektivisering samt digitalisering som lyfts av Anell, Glenngård och Merkur (2012). Samtidigt kan även andra kontextuella faktorer inverka på implementeringen inom privat respektive offentlig vård som lyfts av Glenngård och Malmi (2025).

Då offentliga verksamheter har lyfts som mer byråkratiska samt bestående av aningen mindre engagerade medarbetare enligt Boyne (2002) så riskerar flexibilitet att vara svårare att få igenom i sin helhet inom offentlig sektor. Problematiken med offentlig vård och möjligheterna till implementering av SHRM och organisatorisk rigiditet belyses av Gile, van de Klandert och Buljac-Samardzic (2022), varvid det ter sig som en relativt universell företeelse.

Intervjuerna indikerar samtidigt att lokal autonomi kan fungera som en kritisk resurs för att implementera SHRM, förutsatt att flexibiliteten kombineras med tydlig styrning, mandat och resurser. Detta förstärker teorins antagande att effektiv strategisk HR kräver både central styrning och möjligheter till lokal anpassning, där legitimitet och acceptans hos professionella aktörer är avgörande för genomslag (Paauwe, 2009; Wright & McMahan, 2011).

## 5.4 Profesionella faktorers inverkan på implementering

### 5.4.1 Klinikers logik och arbetsfokus

Empirin visar att en central barriär för HR:s strategiska arbete upplevs vara spänningen mellan klinikernas vardagliga prioriteringar och HR:s strategiska mål. Professioner med hög autonomi, såsom läkare och specialistsjuksköterskor, prioriterar ofta patientflöde och operativa uppgifter framför HR-initiativ, något som även Noordegraaf (2015) samt Spehar, Frich och Kjekshus (2015) tidigare visat vara barriärer. Ofta kopplas motarbetandet till traditioner och professionell identitet där inarbetade arbetsmetoder kopplas till normer och klinisk erfarenhet.

Respondenter indikerar samtidigt att strategiska satsningar kan uppfattas som pålagda eller administrativa, vilket konkurrerar med kärnverksamheten och minskar initiativens genomslag. Detta kan kopplas till studien av Cogin, Ng och Lee (2016) som visade på att omfattande detaljstyrning och kontroll av vårdpersonal riskerar att försämra arbetet genom att skapa mer friktion i arbetsprocesser.

Parallellt framgår det att mottagligheten ökar när HR-initiativ tydligt kopplas till klinisk nytta, mätbara resultat eller teamets arbetsflöden, något som också lyfts av Wright och McMahan (2011) samt Brewster, Chung och Sparrow (2016). Detta överensstämmer med andra studier om SHRM där lokalanpassning och relevans gentemot professionella normer stärker adoption (Greenhalgh et al., 2004; Swanwick & McKimm, 2017). Begränsad representation av HR i ledningsforum förstärker gapet mellan strategiska mål och kliniskt genomförande, vilket skapar behov av relationsbaserade samverkansmekanismer (Fitzgerald et al., 2002; Paauwe, 2009; Rotea et al., 2023). Således kan offentlig sektor riskera att vara relativt mer utsatt för utmaningar genom ökad byråkratisering samt begränsad representation för HR vid beslutsfattande.

### 5.4.2 Professionsnormer och yrkesidentitet

Respondenterna visar att HR ofta uppfattas som administrativt snarare än strategiskt, särskilt bland läkare. Detta skapar en klyfta mellan organisatoriska ambitioner och kliniskt genomförande, vilket kan resultera i passivitet eller selektiv adoption (Townsend, Wilkinson & Allan, 2013; Cogin, Ng & Lee, 2016). HR-initiativ som tydligt kopplas till patientnytta, arbetsförbättring eller karriärmöjligheter möts däremot med större engagemang. Chefer med klinisk bakgrund kan legitimerande implementera strategier, men även de påverkas av perceptionen av administration. Empirin understryker behovet av strategisk översättning, där HR omvandlar policyer till konkreta och relevanta fördelar för klinisk personal (Greenhalgh et al., 2004; Swanwick & McKimm, 2017).

Professionslogik och yrkesnormer framstår som en omfattande barriär för implementeringen av HR:s initiativ där en stark yrkesidentitet hos klinisk personal gör att strategier som uppfattas som styrande möts med motstånd. Samtidigt lyfter både Noordegraaf, (2015), Spehar, Frich och Kjekshus (2015) samt Cogin, Ng och Lee (2016) att personal vana vid teamarbete, formaliserade processer och aningen längre ner i den interna hierarkin i högre grad se HR som en stödjande funktion i stället för styrande. Empirin visar samtidigt att HR ofta uppfattas som administrativt snarare än strategiskt, vilket skapar en klyfta mellan organisatoriska ambitioner och kliniskt genomförande, där framför allt läkare motsätter sig initiativ. Detta är i linje med tidigare fynd av Townsend, Wilkinson och Allan (2013) samt Cogin, Ng och Lee (2016) där initiativ inom vårdsektorn tenderade att mötas av omfattande motstånd från professioner med stark yrkesidentitet.

Initiativ som tydligt kopplas till patientnytta, arbetsförbättring eller karriärmöjligheter får däremot större engagemang, särskilt om interna “champions” fungerar som förespråkare vilket både respondenter samt tidigare forskning i form av Welker et al. (2014), Greenhalgh et al. (2004) samt Rotea et al. (2023) noterat. Sammanfattningsvis visar empirin att professionella normer och yrkesidentitet fungerar både som begränsning och möjliggörare. För att HR ska nå strategiska mål krävs flexibla, kliniskt relevanta och legitimerande strategier som tar hänsyn till professionella normer samt identiteter, autonomi och perceptioner av HR:s roll, vilket även delvis även lyfts av Greenhalgh et al. (2004) samt Welker et al. (2014).

## 5.5 Strategiska möjliggörare

### 5.5.1 Legitimitet och implementering i professionella organisationer

Empirin tyder på att legitimitet utgör en central förutsättning för framgångsrik implementering av SHRM-initiativ i professionella vårdorganisationer. Detta grundar sig i respondenternas upplevda känsla av att tidig involvering och kontinuerlig dialog bidrar till att minska motstånd bland professioner och skapae acceptans för förändringsinitiativ, oavsett sektor. Delaktighet förstås av respondenterna inte enbart som informationsspridning, utan som ett aktivt inkluderande av både medarbetare och chefer i utformning och anpassning av initiativen. Detta ligger i linje med tidigare studier som Wright och McMahan (2011), Paauwe (2009) samt Noordegraaf (2015) som betonar vikten av att integrera HR-praktiker med organisationens mål och professionella normer för att uppnå effektiv implementering.

Metoder som dialogbaserade forum, workshops och pilotprojekt framträder som centrala mekanismer för legitimitetsskapande från intervjuerna. Genom att skapa utrymme för återkoppling och påverkan möjliggörs socialt förankrade förändringar, vilket stärker

engagemang och reducerar passivt motstånd enligt Fitzgerald et al. (2002) samt Greenhalgh et al. (2004). Detta bidrar enligt Spehar, Frich och Kjekshus (2015) till att legitimitet inte enbart byggs genom formella beslut, utan genom processer som erkänns och accepteras inom vårdens professioner.

Vidare understryker empirin chefers och ledares betydelse för implementering, där engagerade chefer fungerar som legitimerande aktörer genom att signalera prioritet, skapa motivation och fungera som länk mellan strategiska ambitioner och den kliniska vardagen. Enligt litteraturen inom SHRM, så som Wright och Nishii (2007), Ulrich (1997) samt Rees och Smith (2021) får ledare och chefer på lokal nivå en central roll i omsättandet av HR-strategier till praktik då de skänker legitimitet åt en åtgärd som annars kan framstå som abstrakt och långt från lokala förutsättning.

Således fungerar lokala ledare som facilatorer som främjar förändring baserat på deras status bland medarbetare. Detta relaterar till interna förändringsagenter, även kallade "change champions", som utifrån deras roll och relation till medarbetare bidrar till förändring. Dessa blir inom kliniker en överbryggande funktion mellan strategiska mål och daglig praktik då informella normer och kollegial legitimitet har stort inflytande enligt Noordegraaf (2015), Kirkpatrick och Ackroyd (2003) samt Ferlie et al. (2013). Koppling till konkreta resultat, såsom förbättrad arbetsmiljö eller patientutfall, förstärker ytterligare initiativens genomslagskraft och legitimitet (Cogin, Ng & Lee, 2016; Gile, van de Klundert & Buljac-Samardzic, 2022). Således blir den strategiska aspekten av en implementering beroendes av lokal legitimitet och omvandling till praktisk verklighet.

### 5.5.2 Strategisk översättare mellan mål och praktik

Intervjuerna indikerar att HR:s strategiska roll i vårdorganisationer i hög grad handlar om att fungera som en översättande länk mellan övergripande organisatoriska mål och den operativa verkligheten i klinisk verksamhet. Respondenterna uppgav i hög grad att HR bidrar till att omsätta strategiska initiativ till konkreta, verksamhetsnära lösningar som kan integreras i vardagliga arbetsprocesser. Enligt litteraturen inom SHRM av Ulrich (1997), Wright och McMahan (2011) samt Becker och Huselid (2006) är detta också den primära uppgiften för HR när det kommer till implementering av strategi då rollens uppdrag är aktivt medskapande snarare än att vara en administrativ funktion.

Dock så är HR:s förutsättningar för att översätta strategi beroende av organisatoriska faktorer, detta då kontextuella skillnader mellan privat och offentlig vård kan rendera i olika former av begränsningar. I dessa sammanhang blir HR:s representation inom beslutsfattande organ avgörande för tidigt strategiskt inflytande (Paauwe, 2009; Townsend, Wilkinson & Allan, 2013). Då privata vårdgivare uppvisar ofta större organisatoriskt handlingsutrymme, underlättas en närmare integration av HR-strategier med kärnprocesser och den kliniska vardagen vilket anges av respondenter samt Gile, Buljac-Samardzic och Klundert (2018).

Samtidigt visar empirin att HR:s strategiska arbete präglas av en inneboende spänning mellan långsiktiga mål och kortsiktiga operativa krav. Kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling och kultur- och värdegrundsarbete behöver balanseras mot omedelbara behov såsom bemanning, rekrytering och administrativa uppgifter. Denna spänning mellan strategiskt och transaktionellt HR-arbete har i tidigare forskning av Cogin, Ng och Lee (2016) samt Paauwe (2009) identifierats som centrala utmaningar att hantera för att HR ska bibehålla legitimitet samt få genomslag i sina implementeringsförsök.

För att hantera denna spänning framträder anpassning till lokala organisatoriska och professionella förutsättningar som avgörande. Anpassning av utbildningsinsatser, ledarskapsprogram och schemalösningar möjliggör att strategiska initiativ får praktiskt genomslag och upplevs som relevanta i den kliniska verksamheten (Kirkpatrick & Ackroyd, 2003; Noordegraaf, 2015). Sammantaget visar analysen att HR:s strategiska funktion i komplexa vårdorganisationer inte enbart handlar om formulering av övergripande initiativ, utan om förmågan att kombinera strategiskt tänkande med praktisk implementering för att uppnå långsiktig effekt och legitimitet. Detta framstår som i linje med tidigare studier av bland andra Paauwe (2009) samt Rees och Smith (2021).

# 6 Diskussion

*Kapitlet diskuterar studiens metodval och empiriska material, analyserar resultaten i relation till tidigare forskning, reflekterar över skillnader mellan offentlig och privat vård samt HR:s strategiska roll samt avslutas med förslag på vidare forskningsområden där empiriskt underlag är begränsat.*

## 6.1 Reflektion kring metod

Studien använde en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka HR-praktiker och strategier inom offentlig och privat vårdsektor. Valet av metod har möjliggjort djupgående insikter i informanternas perspektiv och erfarenheter, vilket är avgörande för att analysera komplexa organisatoriska processer och hinder för SHRM.

Samtidigt medför metodvalet vissa begränsningar som kan påverka resultaten. Intervjuguiden innehöll ett omfattande antal frågor, vilket i vissa fall riskerade att begränsa respondenternas möjlighet att fördjupa resonemang kring specifika teman. Detta kan ha lett till styrda svar snarare än fullständigt öppna reflektioner, där den teoretiska referensramen hade ett stort inflytande på intervjuprocessen. Följden av detta är svar som potentiellt styrts till att bekräfta tidigare studier snarare än att bidra med egna upplevelser från den svenska hälso- och sjukvården. Dessutom har forskarens begränsade erfarenhet av kvalitativ metod potentiellt påverkat följdfrågornas utformning och detaljnivån i intervjuerna.

Urvalet utgör ytterligare en metodologisk begränsning där antalet respondenter var litet och möjligheten att inkludera flera personer från samma verksamhet begränsad, vilket gjorde att vissa organisatoriska dynamiker och interna variationer inte fullt ut kunde fångas. Trots dessa begränsningar har metoden genererat rika data som ger underlag för en analytisk diskussion kring skillnader mellan offentlig och privat sektor samt organisatoriska faktorer som påverkar HR:s strategiska roll. Sammanfattningsvis har metoden har möjliggjort en djupgående insikt, men resultatens generaliserbarhet är begränsad av urval, intervjuguidens omfattning, kontextet och forskarens erfarenhet.

## 6.2 Reflektion kring empiri

Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med representanter från offentlig och privat vårdsektor och utgör studiens centrala grund för analys. Materialet ger en relativt nyanserad inblick i hur HR-funktioner uppfattas och fungerar i praktiken, samt hur organisatoriska och strukturella faktorer påverkar möjligheten att implementera strategisk HRM i ett svenskt kontext. En kritisk aspekt av empirin är dock dess subjektiva karaktär där respondenternas svar speglar individuella erfarenheter, lokala kontextfaktorer och yrkesnormer, vilket innebär att materialet kan vara färgat av personliga uppfattningar. Detta påverkar förståelsen av HR-praktiker och organisatoriska processer och bör beaktas när resultaten tolkas och jämförs mellan sektorer och olika nationella kontext.

Urvalets begränsning medför att vissa interna perspektiv inom verksamheterna saknas. Detta gör att analysen framför allt belyser gemensamma erfarenheter snarare än skillnader inom respektive organisation. Samtidigt möjliggör materialet identifiering av återkommande hinder och möjligheter för HR:s strategiska arbete, såsom organisatoriska strukturer, policyer och resursfördelning, vilket bidrar till förståelsen av skillnader mellan offentlig och privat sektor. Summerat ger empirin värdefulla insikter för analys, men resultaten måste tolkas med försiktighet med tanke på urval, subjektivitet och begränsad intern variation.

## 6.3 Diskussion kring resultat

Analysen av det empiriska materialet visar skillnader mellan offentlig och privat sektor vad gäller HR:s strategiska roll och implementeringen av SHRM. Offentlig sektor präglas av långsammare förändringsprocesser, politisk styrning och en ofta administrativ och reaktiv HR-funktion. Privata vårdorganisationer uppvisar däremot större flexibilitet, snabbare beslutsvägar och ett tydligare resultatfokus, där HR ibland fungerar som strategisk partner i verksamheten. Resultaten måste dock tolkas med försiktighet, urvalet av respondenter var begränsat och relativt homogent avseende arbetsroller och datainsamlingen koncentrerades till en geografiskt koncentrerad region.

Bekvämlighetsurval och kort tidsram kan ha påverkat materialets bredd och vissa lokala organisatoriska nyanser kan därför ha underskattats. Vidare styrs även privata vårdgivare av samma nationella riktlinjer och lagar som offentlig vård, vilket innebär att upplevd flexibilitet primärt relaterar till organisatorisk organisering snarare än faktiska regelverk.

Forskarens roll i datainsamlingen kan även ha påverkat resultaten då användningen av en omfattande intervjuguide bidrog till jämförbarhet mellan organisationer, men begränsade samtidigt möjligheten att fördjupa spontana reflektioner. Trots detta är resultaten relativt konsistenta med tidigare internationell forskning om skillnader mellan offentlig och privat HR-utövande och bidrar med kontextuella insikter om lokal anpassning av HR-strategier inom privat sektor och utmaningen att balansera kortsiktiga resultat med långsiktiga personalinvesteringar.

Överlag bör dock studiens resultat beaktas utifrån realiteten att respondenterna påverkats av egna organisationer som de är anställda av, samt svårigheterna med att återge en nyanserad bild av sin arbetssituation. Då respondenterna i varierande omfång hade erfarenhet av andra sektorn så riskerar upplevelser att påverkas av personliga åsikter och hörsägen.

## 6.4 Relation till tidigare forskning

Den politiska styrningen, med korta mandatperioder och skiftande prioriteringar, framträder dessutom som en förstärkande faktor för denna begränsning, vilket överensstämmer med studier som pekar på hur politisk osäkerhet och externa styrmekanismer kan försvåra långsiktig personalplanering (Lega, Prenestini & Spurgeon, 2013). Samtidigt är det fundersamt hur pass stort inflytande det svenska systemet har på denna upplevelse då både Anell, Glenngård och Merkur (2012) samt Glenngård och Malmi (2025) visat på att skillnader förekommer mellan sektorerna, men att de i grunden verkar utifrån samma förutsättning.

I kontrast angav respondenterna från privata vårdorganisationer att HR-funktionen i högre grad präglas av flexibilitet, snabbare beslutsvägar och en tydligare koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ligger visserligen i linje med teorier om strategisk HRM och resursbaserad teori, där HR framhålls som en central aktör för organisatorisk konkurrenskraft och måluppfyllelse (Barney, 1991; Becker & Huselid, 2006; Wright & McMahan, 2011). Respondenterna beskrev således HR som en strategisk partner med direkt bidrag till affärs- och verksamhetsutveckling, vilket även bekräftas i tidigare forskning (Boxall & Purcell, 2016; Andrieiev et al., 2024).

Huruvida detta enbart är en upplevd erfarenhet eller reell möjlighet blir potentiellt en definitionsfråga av hur mycket anpassningsmöjligheter som kan förekomma inom svensk sjukvård. Då både Anell, Glenngård och Merkur (2012), Glenngård och Malmi (2025) samt Socialstyrelsen (2024) betonar hur svensk vård får bedrivas utifrån samma lagar så

blir organisationer inom privat sektor i viss bemärkelse begränsade rörande hur mycket anpassningar som kan förekomma inom Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Ett mer självständigt bidrag från denna studie är den tydliga betoningen på lokal anpassning av HR-strategier inom privata vårdorganisationer som verkar i det svenska kontextet. Empirin visar att HR i dessa organisationer upplever att de i större utsträckning kan utveckla skräddarsydda lösningar för rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö utifrån lokala enheters behov. Denna aspekt är mindre framträdande i tidigare SHRM-litteratur, där fokus ofta ligger på mer centraliserade och standardiserade strategier (Paauwe, 2009), samtidigt som svensk vård möjligen verkar inom ett eget kontext som lyfts av Glenngård och Malmi (2025). Samtidigt synliggör studien att denna flexibilitet medför en balansgång mellan kortsiktiga resultatkrav och långsiktiga investeringar i kompetens och medarbetare välbefinnande, vilket anknyter till diskussioner om differentierade HR-system.

Sammanfattningsvis bekräftar studien flera etablerade teoretiska antaganden om skillnader mellan offentlig och privat HR-praktik, men bidrar även med en fördjupad förståelse av hur strategisk autonomi och lokala anpassningar påverkar HR:s roll i vårdorganisationer. Resultaten indikerar att HR-logik inte enbart formas av organisatorisk struktur och politisk styrning, utan även av möjligheten att agera kontextnära och strategiskt på lokal nivå. Samtidigt bör resultaten tolkas i ljuset av den svenska välfärdskontexten, där privata aktörer verkar inom ett offentligt finansierat system och med gemensam lagstiftning och till stor omfattning samma kravbild som offentlig vård. Detta innebär att etablerade teorier, ofta utvecklade i andra institutionella kontexter, inte fullt ut fångar komplexiteten i det svenska sammanhanget.

## 6.5 Förslag på vidare forskning

Studien pekar på skillnader mellan offentlig och privat HR-logik inom svensk vård, men har begränsat urval samt låg variation mellan respondenter, vilket begränsar generaliserbarheten. Framtida forskning bör därför inkludera större och mer representativa urval, både nationellt och internationellt, för att jämföra olika typer av vårdorganisationer och system. Longitudinella studier kan potentiellt bidra med djupare insikter i hur HR:s strategiska roll påverkas över tid av politiska beslut, organisatorisk struktur och decentralisering, samt hur implementeringen av SHRM utvecklas under perioder av omfattande förändringar och inverkan av olika innovationer.

Framtida studier bör potentiellt undersöka hur skräddarsydda initiativ på enhetsnivå skapar värde och nytta för patienten, exempelvis genom ökad flexibilitet, effektivitet och tillgänglighet. Avslutningsvis bör framtida forskning fokusera på balansen mellan kortsiktiga resultat, kostnadseffektivitet och långsiktiga investeringar i personalens utveckling samt arbetsmiljö för att förstå hur HR-strategier kan stödja både organisatorisk prestation och hållbar medarbetarutveckling inom den svenska vårdkontexten.

# 7 Slutsats

*Kapitlet summerar studiens syfte och resultat, reflekterar över HR:s strategiska möjligheter och barriärer i offentlig och privat vård, samt kopplar fynden till tidigare forskning i relation till ett svenskt kontext.*

Syftet med studien var att kartlägga hur HR-aktörer i svensk vård uppfattar organisatoriska, professionella och resursmässiga barriärer för implementering av strategisk personalstyrning, samt analysera skillnader mellan offentlig och privat sektor. Resultaten tyder på att HR i offentliga vårdorganisationer i högre grad än privat vård upplever hinder i form av långsamma förändringsprocesser, hierarkiska strukturer och politiskt styrda prioriteringar, vilket begränsar möjligheten att agera strategiskt. I privata vårdorganisationer upplevs HR som mer flexibel, resultatorienterad och ofta strategiskt integrerad, samt med större utrymme att anpassa initiativ till både organisatoriska och lokala behov.

Samtidigt identifieras utmaningen att balansera kortsiktiga resultat med långsiktiga investeringar i medarbetares utveckling och arbetsmiljö. Fynden är till stor del i linje med tidigare forskning om skillnader mellan sektorer för HR, samtidigt som de tillför nya insikter om lokal anpassning och barriärer för implementering. Samtidigt förekommer indikationer på hur ett svenskt kontext inverkar på möjligheterna för SHRM, samt hur HR inom svensk vård relaterar sig till internationella kontext. Resultaten har viktiga implikationer för hur HR kan utvecklas för att stödja både organisatorisk effektivitet och hållbar personalutveckling inom svensk hälso- och sjukvård.

# 8 Referenser

Anell, A., Glenngård, A.H. & Merkur, S., 2012. *Sweden: Health system review*. Health Systems in Transition, 14(5), pp.1–159.

Andrieiev, I., Trehub, D., Khatsko, K., Sokolovska, I., & Ganzhiy, I. (2024). Strategic management in healthcare: the impact of strategic decisions on achieving organizational goals and improving the quality of healthcare services . *Multidisciplinary Science Journal*, *6*, 2024ss0217. https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0217

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, *17*(1), 99-120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2006). Strategic Human Resources Management: Where Do We Go From Here? *Journal of Management*, *32*(6), 898-925. https://doi.org/10.1177/0149206306293668

Bhaskar, R. (1978). *A Realist Theory of Science*. 2nd ed. Brighton: Harvester Press.

Bowles, N. P., McEwen, B. S., & Boutin-Foster, C. (2017). Trouble in transit: Organizational barriers to workers' health. *American Journal of Industrial Medicine*, *60*(4), 350–367. https://doi.org/10.1002/ajim.22701

Boxall, P. and Purcell, J. (2016) *Strategy and Human Resource Management*. 4th ed. London: Palgrave Macmillan.

Boyne, G.A. (2002) 'Public and private management: what's the difference?', *Journal of Management Studies*, 39(1), pp. 97–122. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00284

Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp.77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brewster, C., Chung, C. & Sparrow, P. (2016) *Globalizing Human Resource Management.* 2nd ed. London: Routledge.

Buchan, J. and Aiken, L. (2008) Solving nursing shortages: a common priority. *J Clin Nurs*. 17(24):3262-8. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02636.x.

Christensen, T. and Lægreid, P. (2007), The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. Public Administration Review, 67: 1059-1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x

Cogin, J.A., Ng, J.L. & Lee, I. (2016). Controlling healthcare professionals: how human resource management influences job attitudes and operational efficiency. *Hum Resour Health* 14(55), https://doi.org/10.1186/s12960-016-0149-0

Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. and Karlsson, J. C. (2002). *Explaining Society: Critical Realism in the Social Sciences*. London: Routledge.

Dubois, A. and Gadde, L.-E. (2002). 'Systematic combining: an abductive approach to case research', *Journal of Business Research*, 55(7), pp. 553–560. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00195-8

Ferlie, E., Fitzgerald, L., McGivern, G., Dopson, S., & Bennett, C. (2013). *Making wicked problems governable? The case of managed networks in health care.* Oxford University Press.

Fletcher, A. J. (2016). Applying critical realism in qualitative research: methodology meets method. *International Journal of Social Research Methodology*, *20*(2), 181–194. https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1144401

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, *12*(2), 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Fitzgerald, L., Ferlie, E., Wood, M., & Hawkins, C. (2002). Interlocking Interactions, the Diffusion of Innovations in Health Care. *Human Relations*, *55*(12), 1429-1449. https://doi.org/10.1177/001872602128782213

Freidson, E. (2001) *Professionalism: The Third Logic*. Chicago: University of Chicago Press.

Gile, P.P., van de Klundert, J., & Buljac-Samardzic, M. (2022). Strategic human resource management and performance in public hospitals in Ethiopia. *Front Public Health*. 10:915317. doi:10.3389/fpubh.2022.915317

Gile, P.P., Buljac-Samardzic, M. & Klundert, J.V. (2018). The effect of human resource management on performance in hospitals in Sub-Saharan Africa: a systematic literature review. *Hum Resour Health* 16, 34. https://doi.org/10.1186/s12960-018-0298-4

Glenngård, A.H. & Malmi, T. (2025) 'Exploring differences in performance management across public and private providers in primary care: Evidence from Finland and Sweden', *Health Policy*, 159, p. 105383. doi:10.1016/j.healthpol.2025.105383.

Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: Systematic review and recommendations. *Milbank Quarterly*, 82(4), 581–629. https://doi.org/10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x

Guest, D.E., (2011). Human resource management and performance: Still searching for some answers. *Human Resource Management Journal*, 21(1), pp.3-13. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2010.00164.x

Guest, G., Bunce, A. and Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), pp.59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Kaufman, B.E. (2015), Evolution of Strategic HRM as Seen Through Two Founding Books: A 30th Anniversary Perspective on Development of the Field. Hum Resour Manage, 54: 389-407. https://doi.org/10.1002/hrm.21720

Kirkpatrick, I., & Ackroyd, S. (2003). Transforming the professional archetype? : The new managerialism in UK social services. *Public Management Review*, *5*(4), 511–531. https://doi.org/10.1080/1471903032000178563

Kitchener, M. (2002). Mobilizing the Logic of Managerialism in Professional Fields: The Case of Academic Health Centre Mergers. *Organization Studies*, *23*(3), 391-420. https://doi.org/10.1177/0170840602233004

Kristensen, M. M., Sølvhøj, I. N., Kusier, A. O., & Folker, A. P. (2019). Addressing organizational barriers to continuity of care in the Danish mental health system - a comparative analysis of 14 national intervention projects. *Nordic Journal of Psychiatry*, *73*(1), 36–43. https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1551929

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). *Den kvalitativa forskningsintervjun*. 3rd ed. Lund: Studentlitteratur.

Lega, F., Prenestini, A. & Spurgeon, P. (2013) Is management essential to improving the performance and sustainability of health care systems and organizations? A systematic review and a roadmap for future studies. *Value Health*. 16(1 Suppl):S46-51. doi: 10.1016/j.jval.2012.10.004.

Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. *The Academy of Management Review*, *24*(1), 31–48. https://doi.org/10.2307/259035

Ludvigsson JF, Bergman D, Lundgren CI, Sundquist K, Geijerstam JA, Glenngård AH, Lindh M, Sundström J, Kaarme J, Yao J. (2025). The healthcare system in Sweden. Eur J Epidemiol. 40(5):563-579. doi: 10.1007/s10654-025-01226-9.

Lægreid, P. & Rykkja, L. H. (2015) 'Hybrid Collaborative Arrangements: The welfare administration in Norway – between hierarchy and network', *Public Management Review*, 17(7), pp. 960-980. DOI: 10.1080/14719037.2015.1029349

Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. *The Lancet*, 358(9280), pp.483–488. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05627-6

Martin, G. P., Currie, G. & Finn, R. (2009) 'Leadership, service reform, and public-service networks: The case of cancer-genetics pilots in the English NHS', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(4), pp. 769-794. https://doi.org/10.1093/jopart/mun016

Martineau, T., Mansour, W., Dieleman, M., Akweongo, P., Amon, S., Chikaphupha, K., Mubiri, P. & Raven, J., 2023. Using the integration of human resource management strategies at district level to improve workforce performance: analysis of workplan designs in three African countries. *Human Resources for Health*, 21:57. https://doi.org/10.1186/s12960-023-00838-0

Maxwell, J.A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE.

McHugh, M.D., Kutney-Lee, A., Cimiotti, J.P., Sloane, D.M. and Aiken, L.H. (2011) 'Nurses' widespread job dissatisfaction, burnout, and frustration with health benefits signal problems for patient care', *Health Affairs*, 30(2), pp. 202–210. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2010.0100

Meskó, B., Drobni, Z., Bényei, É., Gergely, B. and Győrffy, Z. (2017). Digital health is a cultural transformation of traditional healthcare. *Mhealth*. 3:38. doi: 10.21037/mhealth.2017.08.07.

Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning: Reconceiving roles for planning, plans, planners. *Free Press*, New York.

Mintzberg, H. (2017) Managing the Myths of Health Care: Bridging the Separations between Care, Cure, Control, and Community. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.

Noordegraaf, M. (2015). Hybrid professionalism and beyond: (New) forms of public professionalism in changing organizational and societal contexts. Journal of Professions and Organization, 2(2), 187–206. https://doi.org/10.1093/jpo/jov002

Nowell, L.S., Norris, J.M., White, D.E. and Moules, N.J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), pp.1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Paauwe, J. (2009), HRM and Performance: Achievements, Methodological Issues and Prospects. Journal of Management Studies, 46: 129-142. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00809.x

Patton, M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

Pettigrew, A. M. (1997). What is a processual analysis? *Scandinavian Journal of Management*, 13(4), 337–348. https://doi.org/10.1016/S0956-5221(97)00020-1

Polder, J.J., & Jochemsen, H. (2000). Professional Autonomy in the Health Care System. *Theor Med Bioeth* 21, 477–491. https://doi.org/10.1023/A:1009977407106

Porter M.E. (2008). Value-based health care delivery. *Ann Surg*. 248(4):503-9. DOI: 10.1097/SLA.0b013e31818a43af

Porter, M.E. (2010) 'What is Value in Health Care?', *New England Journal of Medicine*, 363(26), pp. 2477–2481. https://doi.org/10.1056/NEJMp1011024

Porter, M. E. & Teisberg, E. O. (2006). *Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results*. Boston: Harvard Business School Press.

Rees, G. and Smith, P. (2021). *Strategic human resource management: an international perspective*. 3rd ed. London: SAGE Publications.

Rotea, C. C., Ploscaru, A.-N., Bocean, C. G., Vărzaru, A. A., Mangra, M. G., & Mangra, G. I. (2023). The Link between HRM Practices and Performance in Healthcare: The Mediating Role of the Organizational Change Process. *Healthcare*, 11(9), 1236. https://doi.org/10.3390/healthcare11091236

Salge, T.O. and Vera, A. (2012), Benefiting from Public Sector Innovation: The Moderating Role of Customer and Learning Orientation. *Public Administration Review*, 72: 550-559. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02529.x

Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2023). *Research Methods for Business Students*. 9th ed. Harlow: Pearson Education.

Sayer, A. (2000). *Realism and Social Science*. London: SAGE Publications.

Socialstyrelsen (2024) *About the Swedish healthcare system – Public and private healthcare*, [online] Available at: https://www.socialstyrelsen.se/en/about-us/healthcare-for-visitors-to-sweden/about-the-swedish-healthcare-system/ (hämtad 8 oktober 2025).

Soni, R. & Sharma, R. (2024). 'Job Performance and HRM in Public vs Private Hospitals: Strategic Insights for Organizational Efficiency', *Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal (SHISRRJ)*, 7(5), s. 93-102. https://doi.org/10.32628/SHISRRJ124781

Spehar, I., Frich, J.C. & Kjekshus, L.E. (2012) Clinicians' experiences of becoming a clinical manager: A qualitative study. *BMC Health Services Research*, 12(1), p.421. https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-421

Spehar, I., Frich, & J.C., Kjekshus, L.E. (2015). Professional identity and role transitions in clinical managers. *J Health Organ Manag*.29(3):353-66. doi: 10.1108/JHOM-03-2013-0047.

Swanwick, T., & McKimm, J. (2017). Leadership in health care. In T. Swanwick & J. McKimm (Eds.), *ABC of Clinical Leadership* (3rd ed., pp. 1–6). Wiley-Blackwell.

Townsend, K., Lawrence, S. A. and Wilkinson, A. (2013) 'The role of hospitals' HRM in shaping clinical performance: a holistic approach', *The International Journal of Human Resource Management*, 24(16), pp. 3062–3085. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.775028

Tourangeau, A., Cranley, L., Laschinger, H.K.S. and Pachis, J. (2010) 'Relationships among leadership practices, work environments, staff communication and outcomes in long-term care', *Journal of Nursing Management*, 18(8), pp. 1060–1072. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01125.x

Ulrich, D. and Dulebohn, J. H. (2015) 'Are we there yet? What's next for HR?', *Human Resource Management Review*, 25(2), pp. 188–203. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.004

Ulrich, D. (1997) 'Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results', Boston, MA: Harvard Business School Press.

Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Welker, G., Hobo, A., Danchell, E., Van der Weerd, J. & Ahaus, K. (2014) 'The role of change agents in achieving quality improvement', BMC Health Services Research, 14(Suppl 2): P138. https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-S2-P138

Wright, P.M., Dunford, B.B. and Snell, S.A. (2001) 'Human resources and the resource-based view of the firm', Journal of Management, 27(6), pp. 701–721. https://doi.org/10.1177/014920630102700607

Wright, P.M. and McMahan, G.C. (2011), Exploring human capital: putting 'human' back into strategic human resource management. Human Resource Management Journal, 21: 93-104. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2010.00165.x

Wright, P. M. and Nishii, L. H. (2007) 'Strategic HRM and organizational behavior: Integrating multiple levels of analysis', CAHRS Working Paper Series, No. 468, Cornell University, pp. 1–48.

Yin, R.K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage

Linnéuniversitetet

# Bilaga 1: Mejl till respondenter

**Ämne:** Inbjudan till intervju om strategisk personalstyrning i hälso- och sjukvården

Hej,

Jag heter Robin Weine och skriver just nu min kandidatuppsats vid Linnéuniversitetet. I studien undersöker jag hur strategisk personalstyrning implementeras i hälso- och sjukvården, vilka hinder som kan uppstå samt hur organisatoriska strukturer, professionella normer och invanda arbetssätt påverkar detta.

Jag vill gärna ta del av dina erfarenheter genom en intervju. Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och spelas in, om du samtycker till det. All information hanteras konfidentiellt och anonymiseras i uppsatsen. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange någon anledning.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta eller har några frågor.

Med vänlig hälsning,
Robin Weine
070-5260308
robin.weine@outlook.com

# Bilaga 2: Intervjuguide

**1. Inledning: bakgrund och kontext**

- Kan du kort beskriva din nuvarande roll i organisationen?

- Hur länge har du arbetat här, och vilken erfarenhet har du från andra vårdgivare (offentliga eller privata)?

- Vilken typ av strategiskt HR-arbete är du involverad I, och hur ser din relation ut till HR-funktionen på strategisk nivå?

**2. HR-funktionens roll och strategiska genomslag**

- Hur uppfattar du HR-funktionens roll i den övergripande verksamhetsstyrningen?

- På vilket sätt deltar HR i strategiska beslut, och i vilka sammanhang tycker du deras inflytande är mest respektive minst tydligt?

- Hur avgörs beslut när HR:s syn skiljer sig från linjechefer eller professioner?

- Kan du ge exempel på situationer där HR:s perspektiv har påverkat större verksamhetsbeslut?

- Vilka faktorer upplever du utgör de största hindren för ett ökat strategiskt inflytande för HR?

- I vilken utsträckning påverkar externa krav (lagstiftning, politiska beslut eller ekonomiska ramar) HR:s strategiska roll?

**3. Implementering av personalstrategiska initiativ**

- Kan du ge exempel på personalstrategiska initiativ som har implementerats hos er?

- Hur har dessa initiativ mottagits av olika delar av organisationen – chefer, professioner och ledning?

- Vilka delar av organisationen är oftast drivande, och vilka bromsar eller förhalar initiativen?

- Har ni upplevt att vissa professioner eller organisatoriska nivåer är svårare att engagera i personalstrategiska frågor?

- Hur bedömer du att HR-initiativ följs upp och får fäste över tid?

- Vilka faktorer har varit avgörande för att ett initiativ har lyckats respektive misslyckats?

**4. Professionell autonomi och normer**

- Hur ser du på samspelet mellan HR-strategier och professionell autonomi i organisationen?

- Kan du beskriva ett tillfälle då HR-strategier krockat med professionella värderingar eller arbetssätt?

- Upplever du motstånd mot vissa typer av personalstyrning från medicinska yrkesgrupper?

- Hur påverkar informella normer eller värderingar möjligheten att driva strategiskt HR-arbete?

- Kan du ge exempel på hur olika professioners normer konkret påverkar HR:s möjligheter att implementera strategier?

- Finns det spänningar eller konflikter mellan professionens normer och organisationens styrmodeller?

**5. Mentala barriärer och socialisation**

- Påverkar personalens bakgrund, till exempel yrkesutbildning, deras syn på HR och ledning?

- Ser du skillnader i hur olika yrkesgrupper (t.ex. läkare, sjuksköterskor, chefer) tolkar HR:s roll?

- Har du märkt att personal som byter mellan privat och offentlig verksamhet bär med sig vissa föreställningar eller attityder?

- Hur påverkar dessa föreställningar konkreta beslut och ageranden i organisationen?

- Ser du att ålder eller lång erfarenhet inom offentlig sektor påverkar inställningen till förändring eller HR-initiativ?

- Hur arbetar ni med att förändra invanda arbetssätt eller attityder kopplat till HR-frågor?

**6. Jämförelser mellan privat och offentlig verksamhet**

- Vilka skillnader upplever du finns i hur personalfrågor hanteras mellan offentlig och privat vård?

- Hur märks dessa skillnader i praktiken, exempelvis i styrning, HR-processer, handlingsutrymme eller kultur?

- Tror du att dessa skillnader främst beror på organisatoriska strukturer, styrmodeller eller professionella normer?

- Har föreställningar om "hur det fungerar på andra sidan" (t.ex. offentlig vård är mer byråkratisk eller privat vård mer resultatorienterad) påverkat attityder till HR eller förändringsarbete i din organisation?

- Hur hanteras sådana föreställningar internt – förstärks, motverkas eller används de som argument i strategiska diskussioner?

- På vilket sätt påverkar tidigare erfarenheter från annan sektor individers synsätt eller beteende i den nuvarande organisationen?

- Hur tar organisationen hänsyn till dessa skillnader I sin styrning och planering?

**7. Organisationens styrmodell och strategisk horisont**

- Hur skulle du beskriva organisationens styrmodell, och hur påverkar den möjligheten att driva långsiktiga personalfrågor?

- I vilken grad planeras och hanteras HR-frågor med en långsiktig strategisk horisont jämfört med att vara reaktiva?

- Vilka delar av styrmodellen upplever du främjar respektive hindrar strategiskt HR-arbete?

**8. Reflektioner och avslutning**

- Finns det något vi inte berört som du tycker är viktigt att lyfta när det gäller personalstyrning och organisatoriska hinder?

- Om du fick ändra en sak i organisationens struktur för att stärka strategisk personalstyrning – vad skulle det vara?

- Vad skulle du önska för att förbättra möjligheterna till en mer strategisk HR-funktion i er verksamhet?

- Finns det erfarenheter från andra organisationer (offentliga eller privata) som skulle kunna inspirera förändringsarbete här?

# Bilaga 3: Översikt över respondenter

| Kod/ namn | Sektor | Roll/titel | Arbetslivs-erfarenhet (år) | Utbildning | Kommentar/ särskild erfarenhet |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Offentlig | HR-partner | 11 år (8 år nuvarande, 3 år privat) | Personalvetenskap | Arbetar nära enhetschefer och centrala HR; balanserar operativt och strategiskt HR-arbete; erfarenhet från både privat och offentlig vård; involverad i kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling; anpassar strategier till praktiken |
| O2 | Offentlig | HR-koordinator | ~1 år | Beteendevetenskap | Hanterar operativa HR-uppgifter, stöder chefer i rekrytering och personaladministration; deltar ibland i strategiska HR-möten som observatör; kan analysera beteenden och teamdynamik; erfarenhet av både privat och offentlig vård; lär sig anpassa teorier till praktiska rutiner och regelverk |
| O3 | Offentlig | HR-partner | 4 år (samt >10 år som sjuksköterska) | Leg. sjuksköterska | Kombinerar operativt och strategiskt HR-arbete; klinisk bakgrund ger förståelse för verksamhetens verklighet; arbetar med kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling och regionövergripande strategier; fungerar som brygga mellan central HR och enheter; erfarenhet av påverkan på strategiska initiativ genom dialog med centrala HR-funktioner |
| O4 | Offentlig | HR-koordinator | ~1 år | Personalvetenskap | Arbetar med operativa och administrativa HR-uppgifter inom ett större offentligt sjukhus; fokus på schemaläggning, rekryteringsstöd, introduktion och uppföljning av medarbetarundersökningar; deltar i projektmöten kring strategiska initiativ som kompetensförsörjning och personalutveckling; fungerar som länk mellan central HR och verksamheten genom att översätta strategiska beslut till praktiskt genomförande; samlar in feedback från personal och förmedlar den till strategisk nivå; upplever offentlig HR som komplex men lärorik, med balans mellan regelstyrning och flexibilitet. |
| P1 | Privat | HR Business Partner | 5 år (samt tidigare erfarenhet vid annan vårdinrättning) | Ej specificerad, HR-relaterad erfarenhet | Kombinerar operativt och strategiskt HR-arbete; fungerar som brygga mellan kliniker och HR-avdelning; arbetar med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och HR-initiativ; påverkar beslut lokalt och kan bidra till strategiska beslut inom HR, men är mer rådgivande i medicinska frågor; erfarenhet av internationellt koncerntänk och anpassning till svenska regelverk; flexibilitet och snabb implementering i privat sektor jämfört med offentlig sektor |
| P2 | Privat | HR-direktör | ~7 år (samt internationell erfarenhet inom privat vård) | Ej specificerad, senior HR-erfarenhet internationellt | Strategiskt fokus: kompetensplanering, ledarskapsprogram, HR-mål kopplade till verksamhetens mål; deltar i ledningsgruppens beslut; handledning av HR-avdelning; erfarenhet av internationella HR-modeller och olika organisationskulturer; anpassar internationella metoder till svensk kontext; HR är integrerat i verksamhetens styrning |
| P3 | Privat | Head of People & Organization | 3 år (samt internationell erfarenhet inom | Ej specificerad, erfarenhet av | Strategiskt fokus: organisationsstruktur, ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning, incitamentsprogram och målstyrning; fungerar som brygga mellan linjechefer och central HR; implementerar koncernstrategier på lokal nivå; deltar i ledningsgruppen vid långsiktig resursplanering och utveckling av nya affärsområden |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | healthtech, försäkringsmedicin och privata vårdgivare) | organisationsutveckling och HR-strategi | |
| P4 | Privat | HR-specialist | ~3 år | Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor | Arbetar i gränslandet mellan operativt och strategiskt HR-arbete; ansvarar för rekrytering, introduktion av ny personal, medarbetarundersökningar och kompetensutvecklingsinitiativ; deltar i implementering av strategiska HR-planer initierade på ledningsnivå; fungerar som länk mellan linjechefer och HR-avdelning; ger input i tidiga skeden av strategiska frågor, särskilt kring kompetensförsörjning inom specialistområden; får praktisk erfarenhet av hur HR-strategi översätts till vardaglig verksamhet |

# Bilaga 4: Kodningsschema

| Parent Code | Child Code | Beskrivning |
|---|---|---|
| Kontextuella skillnader | Offentlig sektor | Utsagor om hur offentlig förvaltning, politisk styrning, regelverk och långsammare beslutsvägar påverkar implementeringen av SHRM. |
| | Privat sektor | Utsagor om hur marknadslogik, effektivitet, kortare beslutsvägar och mer flexibla strukturer påverkar implementeringen av SHRM. |
| | Resursramar och budgetprocesser | Beskriver hur ekonomiska förutsättningar, budgetcykler och prioriteringslogiker skapar olika organisatoriska villkor för HR-arbetet. |
| | Skillnader i professionell autonomi mellan sektorer | Fångar variationer i hur stark klinisk autonomi är, och hur detta skiljer sig mellan huvudmän och påverkar implementeringen av HR-strategier. |
| | Styrningslogiker | Utsagor om hur olika styrmodeller (t.ex. New Public Management, marknadsstyrning, processtyrning) präglar organisationernas arbetssätt och HR:s roll. |
| Organisatoriska hinder | Centralisering vs lokal anpassning | Utsagor om hur hög grad av central styrning minskar lokalt handlingsutrymme och försvårar kontextanpassade HR-lösningar. |
| | Hierarkier och fragmentering | Beskriver organisatoriska silos, långa beslutsvägar och bristande samordning mellan nivåer/enheter. |
| | HR:s position i organisationen | Fångar hur HR uppfattas – som administrativt stöd eller strategisk partner – och hur legitimitet och mandat varierar. |
| | Otydlig ansvarsfördelning | Utsagor om oklara roller mellan HR, linjechefer, klinikledning och verksamhetsstyrning. |
| | Resursbegränsning och policyhinder | Beskriver organisatoriska begränsningar kopplade till budget, bemanning, policys eller administrativa system. |
| | Transaktionell vs strategisk HR | Utsagor om hur HR fastnar i operativt/administrativt arbete istället för strategiskt arbete, och varför. |

| | | |
|---|---|---|
| Professionella hinder | Klyfta mellan klinik och HR | Utsagor som beskriver distans, misstro eller bristande samförstånd mellan kliniska professioner och HR-funktioner. |
| | Motstånd eller selektiv adaptation | Beskriver hur kliniker tar till sig, omformar eller motstår HR-initiativ utifrån professionens normer och prioriteringar. |
| | Normer och värderingar / professionslogik | Utsagor om hur professionell identitet, kollegiala normer och kliniska värderingar påverkar acceptansen för HR-strategier. |
| | Professionell autonomi | Kliniska yrkesgruppers självbestämmande och hur top-down-beslut, standardisering eller HR-initiativ upplevs som hot mot yrkets autonomi; påverkan på mottagande av HR:s förändringsarbete. |
| | Uppfattning om administrativ uppgift | Beskriver hur HR- och organisationsfrågor ses som sekundära, administrativa eller mindre legitima jämfört med kliniskt arbete. |
| Strategiska mekanismer | Delaktighet och engagemang | Utsagor som betonar vikten av involvering av kliniker, chefer och andra aktörer i HR-processer. |
| | HR som strategisk partner / brobyggare | Fångar exempel där HR lyckas skapa relationer, legitimitet och inflytande mellan organisatoriska nivåer. |
| | Ledarskap och förändringsagent | Utsagor om chefers, HR:s eller andra aktörers roll i att driva förändring och skapa förutsättningar för SHRM. |